Dipartimento Assistenziale Integrato Salute Mentale-Dipendenze Patologiche

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

Report di Attività

Dipartimento Assistenziale Integrato

Salute Mentale

Dipendenze Patologiche

2020

a cura

dell'Ufficio Sistema Informativo

e

dell'Osservatorio sulle Dipendenze

Sommario

Presentazione	3
Introduzione	4
Nota metodologica	6
La mappa dei Servizi del DAI-SMDP	8
I programmi del DAISM-DP	14
L'Utenza del DAI-SMDP	16
NEUROPSICHIATRIA DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA	19
Disturbi Specifici di Apprendimento.	21
Percorso 0-3 anni	22
Percorso di cura e tutelaminori	22
Residenze per Minori di San Polo di Torrile	23
PSICHIATRIA ADULTI	25
I Centri di Salute Mentale (CSM)	25
Residenze e Budget di Salute	27
Interventi psicosociali /Attività' Riabilitative /Gruppi di Auto Mutuo Aiuto (AMA)	31
Attività Ospedaliera	32
PROGRAMMI / PERCORSI	35
Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA)	35
Percorso Esordi Psicotici	36
Programma Regionale Integrato Autismo (PRIA) /Disturbi dello Spettro Autistico (ASD)	38
Programma adolescenza e giovane età adulta	40
Programma Salute Mentale nei Percorsi Giudiziari	40
PROGRAMMA DIPENDENZE PATOLOGICHE	46
Unità di strada	52
Ambulatorio per Accertamenti Medico Legali dell'Area Dipendenze Patologiche (AMLDP)	57
Tabagismo: Centro Anti Fumo (CAF)	58
Attività del Comitato Utenti e Famigliari	60
Appendice	61
Note conclusive	62

Presentazione

Il 2020 è stato caratterizzato dalla pandemia da Covid 19 che ha determinato una grave crisi sanitaria, sociale ed economica che è stata affrontata con grande impegno, professionalità e partecipazione, etica e responsabilità. Una situazione che purtroppo ancora deve essere superata e condiziona la programmazione, progettazione, realizzazione delle attività del 2021 che vedono procedere, secondo le indicazioni della Regione Emilia Romagna, il programma per l'unificazione delle Aziende Sanitarie di Parma.

Le drammatiche vicende connesse alla pandemia hanno evidenziano quanto sia fondamentale per tutti il Sistema Sanitario Nazionale e Regionale. In particolare la continuità delle attività tra ospedale e territorio per far fronte alla tipologia e alla complessità dei disturbi, caratterizzati da molteplici aspetti biologici, psicologici e sociale. In questo ambito, il Dipartimento Assistenziale Integrato Salute Mentale e Dipendenze Patologiche rappresenta un presidio fondamentale per la salute dei cittadini e il benessere delle comunità. Il Report annuale del Dipartimento Assistenziale Integrato Salute Mentale e Dipendenze Patologiche rappresenta da diversi anni un documento di rendicontazione e al contempo di riflessione. Ringrazio vivamente i professionisti del Dipartimento per il loro lavoro quotidiano con il quale contribuiscono in modo determinante alla valorizzazione e allo sviluppo del sistema di welfare.

Il Commissario Straordinario dell'Azienda Usl di Parma

Dott.ssa Anna Maria Petrini

Introduzione

Il 2020 segna una discontinuità: la pandemia da Covid 19 per la sua gravità e pervasività ha interessato tutti gli aspetti della vita individuale, familiare, sanitaria, sociale, educativa, culturale, sportiva, produttiva, incidendo sugli stili di vita e le forme di relazione tanto da parlare di "sindemia". La pandemia ha evidenziato la rilevanza del sistema sanitario pubblico e universalistico dove il prendersi cura di Sé e dell'Altro, nella reciprocità, mantenendo la "giusta distanza" e le necessarie precauzioni è diventato essenziale per la salute di ciascuno e di tutti. Siamo inevitabilmente interconnessi e co-esistenti in un destino comune. Lo stress da acuto è diventato cronico, ormai dura da oltre un anno e per quanto vi siano speranze dovute ai vaccini, ancora lunga sembra la strada per uscirne. Dobbiamo resistere e riorganizzare le attività a lungo termine, abbandonando l'idea che a breve saremo nel post Covid. Le aspettative sono fondamentali per la salute mentale, un bene individuale e relazionale, un diritto che deve a realizzarsi nella quotidianità. Un bene molto prezioso, senza il quale non c'è salute, benessere familiare, sociale e che oggi vede una marcata sofferenza delle giovani generazioni private del futuro e nel presente anche della scuola, della sport, della socialità e delle manifestazioni culturali. Ancora le donne e tutti i soggetti vulnerabili si sono trovati a vivere condizioni di isolamento per il venire meno di molte relazioni sociali, di mediazione, incontro reale e sono aumentate le violenze, le problematiche familiari, l'isolamento. Una fragilità che arriva ad interessare tutti.

Le relazioni mantenute attraverso internet hanno creato opportunità ma al tempo stesso nuove forme di emarginazione e abbandono. Non mancano positive esperienze di resilienza, di solidarietà volte a mantenere e ricreare forme possibili di socialità, di micro-socialità, di vicinato. Sforzi per andare avanti si colgono in tutti gli ambiti ma la pandemia attraversa ogni ambito, rimodella, riduce il connettivo, interroga su diritti e doveri,suconsenso e responsabilità tanto invocati anche di fronte alla pandemia che ha colpito fortemente tutti i contesti chiusi e istituzionali facendo riflettere su come la cura debba realizzarsi il più possibile nella comunità, a domicilio della persona. L'organizzazione sanitarie e sociale deve mostrare una rinnovata capacità per adattarsi alle mutate esigenze di cura in un contesto sociale e familiare profondamente cambiato per la pandemia, la rivoluzione informatica, i cambiamenti climatici e le migrazioni, le culture e le tipologie di famiglie.

Le attività di prevenzione, di diagnosi, cura e riabilitazione, di valutazione della soddisfazione dell'utenza tutte tra loro variamente collegate e interagenti, seppure rimodulate sono state mantenute anche nel corso della pandemia. Si sono ulteriormente sviluppati i Programmi e Percorsi Diagnostico Terapeutico Assistenziali (PDTA) unendo aggiornate competenze tecnico-scientifiche ed etica, rispetto della dignità, valorizzazione della volontà e del punto di vista della persona. Anche l'attenzione agli aspetti gestionali è sempre declinata ad assicurare il diritto alla salute, diritto fondamentale della persona e al contempo interesse della comunità.

Con soddisfazione presento il Report di attività 2020 del Dipartimento Assistenziale Integrato Salute Mentale e Dipendenze Patologiche (DAI-SMDP) che vede una diffusa rete territoriale e molteplici collaborazioni con: Università di Parma, l'Ospedale Privato Accreditato "Maria Luigia", Cooperazione Sociale, Consorzio delle

Cooperative, Consorzio Zenit, Auoradomus, Consorzio Fantasia, Gruppo CEIS, Betania, Casa Lodesana, Fondazione Don Gnocchi e Fondazione Bambini e Autismo.

Il Comitato Utenti e Familiari e i Gruppi di Automutuoaiuto collaborano alle attività di programmazione, gestione e valutazione del dipartimento.

Per la salute mentale e il benessere sociale sono essenziali il sistema di comunità, il clima sociale di accoglienza e inclusione, i diritti sociali e quindi il ruolo dei Comuni, delle articolazioni produttive, del volontariato.

Nel 2020 è stato installato il nuovo sistema informativo regionale CURE (Cartella Unica Regione Emilia Romagna) che ha consentito il passaggio dalla documentazione cartacea a quella informatica ed una maggiore fruibilità dei dati.

Come gli scorsi anni il Report è stato redatto selezionando i dati più significativi prestando attenzione alle più significative variazioni intervenute nel 2020. L'anno segna una crisi che probabilmente è ancora in parte invisibile e sommersa, quindi non ancora pienamente percepita dai servizi che tuttavia colgono il crescente malessere, la tensione sociale, la disperazione, le povertà economica, educativa e culturale.

I dati possono essere approfonditi e utilizzati per studi e ricerche che mi auguro possano essere intraprese anche dai tanti studenti e specializzandi che ogni anno frequentano i servizi.

Un elogio va ai redattori del rapporto per la chiarezza e la sintesi. Infine, come sempre, il mio pensiero va alle persone che soffrono, alla loro sensibilità e umanità che mi pare non vada mai dimenticata anche quando presentiamo dati epidemiologici e si rendicontano attività di servizio con i numeri a volte apparentemente freddi e lontani dall'esperienza umana.

Il Direttore DAI-SMDP

Pietro Pellegrini

Nota metodologica

Oggetto di analisi del presente *Report* sono i dati riguardanti l'attività e l'utenza del DAI-SMDP di Parma nel periodo compreso tra il 01/01/2020– 31/12/2020, confrontati laddove possibile con quelli degli anni precedenti.

Le fonti sono i Sistemi Informativi della Salute Mentale Adulti (EFESO) e dal novembre 2020 da CURE, della Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza (ELEA), dei Servizi per le Dipendenze Patologiche (SISTER), dell'Unità di Strada (SISTER e Schede RER), il sistema SDO per i Servizi Psichiatrici Ospedalieri. Nella prima parte del Report, dopo la mappa dei servizi del DAI-SMDP,vengono presentati i numeri degli accessi ai Servizi del DAI-SMDP. Per ogni Area Disciplinare l'elaborazione dei dati è stata successiva all'identificazione univoca degli utenti nei singoli database clinici, al fine di evitare doppi conteggi. Quando un utente è stato in carico a più Servizi della stessa Area Disciplinare è stato attribuito all'ultimo servizio che lo ha avuto in cura nell'anno di riferimento. Il conteggio degli accessi è avvenuto calcolando i "*soggetti con almeno una prestazione nell'anno di riferimento*". Per il computo del rapporto utenti/popolazione residente sono stati utilizzati i dati sulla popolazione pubblicati online dal Servizio Statistico della Regione Emilia Romagna (https://statistica.regione.emilia-romagna.it/).Al fine di rendere i dati confrontabili è stata utilizzata una definizione condivisa di "utente in carico" che corrisponde a "*soggetto con progetto/programma terapeutico aperto e almeno una prestazione nell'anno di riferimento*" relativa ad una diagnosi pertinente alla presa in carico. Le diagnosi sono formulate in base alla Classificazione Internazionale delle Malattie (ICD9) per la Salute Mentale Adulti, (ICD10) per i Servizi Dipendenze Patologiche e la Neuropsichiatria Infantile. Va infine precisato che nel novembre 2020 ha preso avvio il nuovo sistema informativo regionale e la Cartelle Unica Regione Emilia Romagna (CURE) che diverrà comune a tutte le aree disciplinari.

Di seguito le principali sigle utilizzate nel report:

NPIA: Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza
PA: Psichiatria Adulti
DAI-SMDP: Dipartimento Assistenziale Integrato Salute Mentale Dipendenze Patologiche
DP: Dipendenze Patologiche
CSM: Centro di Salute Mentale
SerDP: Servizi Dipendenze Patologiche
SMA: Salute Mentale Adulti
SPDC: Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura
SPOI: Servizio Psichiatrico Ospedaliero Intensivo

PLS: Pediatra Di Libera Scelta

La mappa dei Servizi del DAI-SMDP

La mappa dei servizi del DAI-SMDP suddivisi per Aree disciplinari e distribuiti nei Distretti di Parma comprende tutte le articolazioni operative territoriali, residenziali ed ospedaliere mentre le modalità di accesso sono precisate nella Carta dei Servizi (link al sito Ausl).

Il DAI-SMDP comprende le Aree Disciplinari di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza (NPIA), Salute Mentale Adulti (SMA) e Dipendenze Patologiche (DP) .

Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza

La NPIA si occupa dei disturbi neurologici, neuromotori, neuropsicologici, psichiatrici e psicologici dell'infanzia e dell'adolescenza. Svolge attività specialistica di prevenzione, diagnosi, terapia e riabilitazione per i soggetti in età evolutiva (0-17 anni) e per le loro famiglie. Oltre ai Centri di NPIA (CNPIA), l'area comprende la Residenza a Trattamento Intensivo (RTI) per minori di S.Polo di Torrile a valenza Area Vasta Emilia Nord (AVEN) e il Centro per la diagnosi, la cura e lo studio dei disturbi della comunicazione e della socializzazione di Parma. Collaborano anche Fondazioni, Cooperative e Ospedalità Privata Accreditata.

Dipendenze Patologiche

L'Area Dipendenze Patologiche mira alla tutela e promozione della salute, alla cura, al recupero e alla prevenzione delle dipendenze patologiche delle persone nella fascia target dai 15 ai 64 anni. Si articola in un Programma con funzioni di indirizzo, in SerD distrettuali, in una UOS dedicata ai problemi alcol correlati. Sono previstiProgrammi di prevenzione e contrasto e cura del tabagismo e del gioco d'azzardo patologico ed è attiva un'Unità di Strada finalizzata agli interventi di prossimità e "bassa soglia".Fanno parte della rete gli Enti Accreditati.

Salute Mentale Adulti

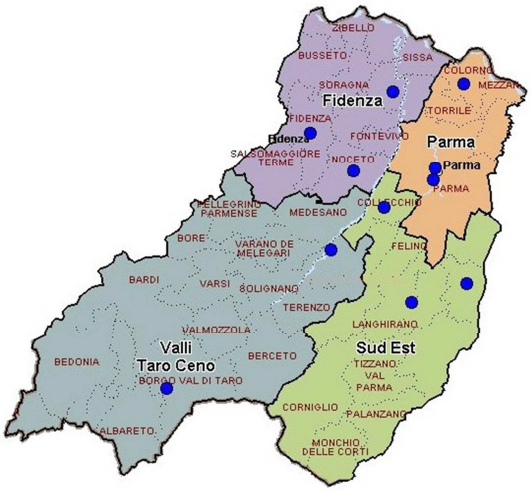
L'area della Salute Mentale Adulti si occupa della diagnosi, cura e riabilitazione dei disturbi mentali della popolazione adulta. Contribuisce alla prevenzione del disagio ed alla promozione del benessere psichico dei cittadini attraverso la programmazione congiunta con gli Enti Locali e l'attuazione di interventi socio-sanitari integrati. Realizza i propri interventi in ambito territoriale, semi-residenziale, residenziale e ospedaliero. I Centri di Salute Mentale (CSM) assicurano la continuità assistenziale mantenendo la titolarità e la responsabilità dei percorsi di cura.

Il DAI-SMDP dispone di una rete di Semiresidenze e di Residenze Sanitarie e Socio-Sanitarie a diversi livelli di intensità di cura e di appartamenti assistiti, ed attua Programmi Personalizzati con Budget di Salute con la collaborazione degli Enti del Terzo Settore.

La rete ospedaliera psichiatrica è costituita dai Servizi Psichiatrici Ospedalieri (SPO) a direzione Universitaria e dai posti SPOI convenzionati presso l'Ospedale Privato Accreditato "Maria Luigia".
Provvede all'erogazione degli interventi di competenza ospedaliera negli ambiti dell'emergenza-urgenza, in collegamento coi servizi territoriali; garantisce inoltre un'attività ambulatoriale per visite specialistiche, di secondo livello, integrata all'interno del "Progetto Leggieri" e, in funzione dell'afferenza universitaria, ha competenze didattiche e di ricerca.

Nelle tabelle sono riportate tutte le Strutture Territoriali, Residenziali ed Ospedaliere, sia a gestione diretta AUSL, sia quelle in rapporto di accreditamento o convenzionale. Si tratta di una rete molto ampia di 42 punti ambulatoriali (12 della Npia, 20 della Psichiatria e 10 delle Dipendenze), 22 Residenze (18 per Psichiatria, 3 Dipendenze e 1 per Npia), i Servizi Psichiatrici Ospedalieri a direzione universitaria e Ospedale Privato "Maria Luigia".

I servizi della Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza



Distretto	Indirizzo	Unità Operativa/Servizio
Parma	Viale Fratti 32/1A	Casa della Salute per il Bambino e l'Adolescente U.O. di Psichiatria e Psicologia Clinica-Infanzia e Adolescenza Centro per l'Adolescenza e Giovane Età (C.A.G.E.) U.O. di Neurologia Funzionale e della Riabilitazione U.O. Integrazione Socio-Sanitaria di Minori con Patologie Neuropsichiatriche
	Via Spezia 147 – Parma	Centro per la diagnosi, la cura e lo studio dei disturbi della comunicazione e della socializzazione
	Via Suor Maria 3 – Colorno	Ambulatorio NPIA di Colorno
Fidenza	Via Don Tincati, 5 – Fidenza	U.O. Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza
	P.za C. Alberto Dalla Chiesa, 30 – Noceto	Ambulatorio NPIA di Noceto
	Piazza Martiri della Libertà, 24 - San Secondo	Ambulatorio NPIA di San Secondo
Sud Est	Via Roma, 42/1 – Langhirano	U.O. Neuropsichiatria Infantile e Adolescenza
	Via Berlinguer, 2 – Collecchio	Ambulatorio NPIA di Collecchio
	Via IV Novembre, 33 – Traversetolo	Ambulatorio NPIA di Traversetolo
Valli Taro e Ceno	Via Solferino, 36 – Fornovo	U.O. Neuropsichiatria Infantile e Adolescenza
	Via Benefattori, 12 - Borgo Val di Taro	Ambulatorio NPIA di Borgotaro
Residenze	Piazzale Pertini 2, S.Polo di Torrile (PR)	Residenza Sanitaria a Trattamento Intensivo per Minori per Area Vasta Emilia Nord
Servizi convenzione		Fondazione "Bambini e autismo ONLUS" Fidenza
		Fondazione Don Gnocchi Parma
		Ambulatorio NPIA Ospedale privato accreditato "Maria Luigia"
		Coop. Aurora Domus, Proges, Consorzio Cooperative Sociali

I servizi della Psichiatria Adulti



Distretto	Indirizzo	Unità Operativa/Servizio
Parma	Largo Natale Palli, 1 - Casa della Salute Parma Centro	Centro Salute Mentale "Parma Est"
	Via Giorgio Vasari 13 – Parma	Centro Salute Mentale "Parma Nord-Ovest"
	Via Suor Maria 3 – Colorno	Ambulatorio CSM di Colorno
	Via del Donatore 2 – Sorbolo	Ambulatorio CSM di Sorbolo
Fidenza	Via Berenini 153 – Fidenza	Centro Salute Mentale di Fidenza
	Via Roma 1, Salsomaggiore Terme	Ambulatorio CSM di Salsomaggiore
	Piazza Martiri libertà 1 - San Secondo	Ambulatorio CSM di San Secondo
	Via XXV Aprile 2 – Busseto	Ambulatorio CSM di Busseto
	Via Dalla Chiesa 30 – Noceto	Ambulatorio CSM di Noceto
	Via XXIV Maggio 16- Fontanellato	Ambulatorio CSM di Fontanellato
	Via Mazzini 20- Soragna	Ambulatorio CSM di Soragna
Sud Est	Via Roma 42/1- Langhirano	Centro Salute Mentale di Langhirano
	Via Rosselli 1- Collecchio	Ambulatorio CSM di Collecchio
	Via IV Novembre 33 – Traversetolo	Ambulatorio CSM di Traversetolo
Valli Taro e Ceno	Via Solferino 37 – Fornovo	Centro Salute Mentale di Fornovo
	Via Benefattori 12, Borgo Val di Taro	Ambulatorio CSM di Borgotaro
	Piazza Rastelli 2 – Medesano	Ambulatorio CSM di Medesano
	Via Arandora Star 11, Bardi	Ambulatorio CSM di Bardi
Servizi Ospedalieri	Viale Gramsci 14 - Parma - Padiglione "Braga" (presso Ospedale Maggiore)	Servizio Psichiatrico Ospedalieri a Direzione Universitaria. Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC)
		Servizio Psichiatrico Ospedaliero Intensivo (SPOI) e D.H.

	Via Montepelato Nord 41, Monticelli Terme (Pr)	Ospedale Privato Accreditato "Maria Luigia"
Residenze Sanitarie	Via Don Tincati5, Vaio (Pr)	Residenza a Trattamento Intensivo- Presidio Residenziale Psichiatrico (PRP)
	Via Vasari 13, Parma	Residenza a Trattamento Intensivo "F. Santi"
	Via Roma 16, Colorno (Pr)	Residenza per trattamenti riabilitativi psicosociali a medio termine a carattere estensivo (RTR-E) " 1° Maggio"
	Via IV Novembre 2, Casale di Mezzani (Pr)	Residenza per l'Esecuzione delle Misure di sicurezza (REMS) Casale di Mezzani
	Via Davalli 5, Salsomaggiore (Pr)	Residenza a trattamento Socio-Sanitaria "Il Villino"GestionePro.Ges
	Via Farnese 17, Vigheffio (Pr) -	Residenza per trattamenti riabilitativi psicosociali a medio termine a carattere estensivo (RTR-E) Protratto "La Fattoria di Vigheffio"gestionePro.Ges
Residenze Socio sanitarie	Via Mordacci 10, Parma	Comunità Alloggio "Casamica" gestioneCons. Zenit (Pro.Ges)
	Via Cocconcelli 3, Parma	Gruppo AppartamentogestioneCabiria
	Via Mamiani della Rovere 5, Parma	Gruppo AppartamentogestioneCons. Zenit (Pro.Ges)
	Via Verona 54, Parma	Gruppo AppartamentogestioneCons. Solid. Soc. (Avalon)
	P.le Passo del Ticchiano 7, Parma	Gruppo Appartamento gestione Cons. Solid. Soc. (Sirio)
	Strada Comunale Paullo, 22,Parma	Residenza Sanitaria a Trattamento Socio-Riabilitativo per Disturbi Comportamento Alimentare "In Volo" gestione CEIS
	Via Roma 51, Pellegrino Parmense	Comunità Alloggio "L' Appennino" gestioneAuroradomus
	Via Davalli 5, Salsomaggiore (Pr)	Gruppo Appartamento gestione Pro.Ges
	Via Farnese 17, Vigheffio (Pr)	Gruppo Appartamento "La Fattoria" di Vigheffio gestione Pro.Ges
	Via Montale 4, Pontetaro di Noceto	Gruppo appartamento "Villino di Pontetaro"" gestione Cons. Zenit (Pro.Ges)
	Via Micheli 1, Pellegrino Parmense (Pr) -	Gruppo Appartamento "Corsini "Pellegrino Parmense gestione Auroradomus
	Via Bracchi 10, Felino (Pr)	Gruppo appartamento "Armonia" gestione K.C.S. CaregiverCoop.a.r.l
Centri Diurni	Via Vasari 13, Parma	Centro Diurno "Santi" - Progetto "Le Viole"

I servizi per le Dipendenze Patologiche



Distretto	Indirizzo	Unità Operativa/Servizio
Parma	Strada dei Mercati 15/b – Parma	SerDP Parma
	Strada dei Mercati 7 – Parma	Drop-In – Unità di Strada
	Via Gaime Pintor, 1 – Parma	Centro Antifumo
	Via Vasari, 13/a – Parma	Amb.per gli Accertamenti Medico Legali
	Via Suor Maria 3 – Colorno	Ambulatorio di Colorno
	Strada Burla, 59 – Parma	U.O Salute Mentale Dipendenze Patologiche negli Istituti Penitenziari (N.A.R.T).
Fidenza	Via Berenini 153 – Fidenza	SerDP Fidenza
Sud Est	Via Roma 42/1 - Langhirano	SerDP Langhirano
Valli Taro e Ceno	Via Benefattori 12, Borgo Val di Taro	Ambulatorio SerDP. di Borgo Val di Taro
	Via Solferino 37 – Fornovo	Ambulatorio SerDP. di Fornovo
Enti Ausiliari	Via del Lazzaretto 26, Marore (PR)	Cooperativa sociale *Comunità Betania*
	Via Martiri Liberazione 121, Vicofertile (PR)	Fondazione CEIS ONLUS
	Via Cabriolo 75, Fidenza (PR)	Comunità “Casa di Lodesana”

I programmi del DAISM-DP

Il DAI-SMDP ha un organizzazione "a matrice" e integra il riferimento territoriale delle Unità Operative, con uno di tipo funzionale costituito dai Programmi/Percorsi. Questi sono complessi di attività che assicurano l'unitarietà delle programmazioni, dell'organizzazione, della valutazione, della qualità dei percorsi diagnostico terapeutico assistenziali. Prevedono il coinvolgimento di competenze di diverse Strutture Complesse e/o di diverse Aree Disciplinari del DAI-SMDP, di altri Dipartimenti o interaziendali, o servizi di area Vasta o Regionali.

Programma Dipendenze Patologiche

Il Programma Dipendenze Patologiche svolge funzioni di coordinamento, indirizzo, unitarietà degli interventi nell'ambito delle dipendenze patologiche. Nello specifico si occupa dello sviluppo organizzativo e professionale del sistema di cura delle dipendenze, anche in relazione all'ospedalizzazione in Strutture pubbliche e private accreditate; del rapporto col privato sociale e, in particolare, applicazione locale degli accordi Regione-Coordinamento Enti Ausiliari; del supporto ai Distretti in ordine all'integrazione sociosanitaria (prevenzione, prossimità, reinserimento sociale e lavorativo, riduzione del danno) e collaborazione con gli Enti Locali per l'attuazione degli interventi.

Al Programma afferiscono anche Unità di strada, Centro Studi e Osservatorio Epidemiologico.

Programma Adolescenza e Giovane Età

Il Programma dipartimentale per l'Adolescenza e la Giovane Età fornisce risposte alla psicopatologia dell'adolescenza, a partire dai servizi di NPIA, mediante azioni di integrazione tra le competenze presenti nelle UO di Psichiatria Adulti e SerDP, nonché attraverso un forte collegamento con professionisti ed agenzie che a vario titolo incontrano gli adolescenti (Pediatri di Libera Scelta, Medici di Medicina Generale, insegnanti, Consultori Giovani, servizi di prossimità, Servizi Sociali etc.), con l'obiettivo di identificare precocemente l'insorgenza di disturbi potenzialmente gravi, avviando interventi tanto più efficaci quanto più tempestivi. Assicura mediante l'Equipe Funzionale il passaggio all'età adulta.

Programma per i Disturbi dello Spettro Autistico

In attuazione al Programma Regionale Integrato Autismo (PRIA) è stato sviluppato Il Programma per i Disturbi dello Spettro Autistico finalizzato alla promozione della salute, alla diagnosi precoce e alla qualificazione dei percorsi di cura in materia, a garanzia di appropriatezza e continuità assistenziale.

Sono stati individuati, in ogni CSM, referenti per le persone adulte affette da Autismo, che lavorano in continuità con la NPIA.

Il Programma si raccorda con la struttura di riferimento per l'Area Vasta Emilia Nord e opera in maniera integrata con i servizi sociali degli Enti locali, la Fondazione "Bambini e Autismo", la Cooperazione sociale, Associazioni dei familiari, Ufficio scolastico e Università di Parma, con la quale è stato predisposto uno specifico protocollo per favorire l'accesso all'università delle persone affette da Autismo.

Il Programma per i Disturbi del Comportamento Alimentare

Il Programma, responsabile della corretta applicazione del PDTA interaziendale, è finalizzato alla promozione della salute, alla diagnosi precoce e alla qualificazione dei percorsi di cura in materia, a garanzia di appropriatezza, efficacia e continuità assistenziale articolata nei livelli ambulatoriale, semiresidenziale, ospedaliero e residenziale. L'Azienda USL di Parma, ha individuato formalmente un team aziendale dedicato all'assistenza ai pazienti con DCA.

Programma Esordi Psicotici

E' un programma strategico per la prevenzione e l'intervento precoce di disturbi mentali gravi. Lo specifico PDTA è finalizzato al miglioramento del percorso clinico-assistenziale, attraverso l'ottimizzazione del sistema di intercettazione, la riduzione della variabilità di valutazione e trattamento, la garanzia di una presa in carico integrata finalizzata alla recovery, anche attraverso la costruzione di reti di prossimità e il coinvolgimento attivo degli utenti in qualità di esperti per esperienza.

Sono presenti anche i seguenti PDTA:

PDTA per i Disturbi dell'Attenzione e Iperattività (ADHD/DDA)

PDTA Gioco D'Azzardo Patologico

Nel 2020 è stato completato il PDTA "Multicomplessità" e sono in corso si stesura quello per i Gravi Disturbi della Personalità e per i Disturbi dovuti all'Alcool.

I Cruscotti gestionali monitorano i Percorsi trasversali a più articolazioni e aree disciplinari:

- percorso Budget di Salute e residenzialità sanitaria e sociosanitaria
- ricoveri psichiatrici in E-U (presso SPDC, SPOI, RTI, Ospedale Privato Accreditato Villa Maria Luigia)
- inserimenti in Comunità Terapeutiche Area DP
- inserimenti in strutture residenziali NPIA e collocazioni extrafamiliari di minori
- programmi clinici in percorsi giudiziari

L'Utenza del DAI-SMDP

Nella tabella 1 sono riportati i dati al 01/01/2021, relativi alla popolazione di ogni singolo distretto che rappresenta la base territoriale per i servizi del DAI-SMDP. I valori relativi alle tre popolazioni *target* di riferimento: da 0 a 17 anni per la NPIA, di età superiore ai 18 anni per la Psichiatria Adulti e tra 15 e 64 anni per le Dipendenze Patologiche. (fonte: https://statistica.regione.emilia-romagna.it/servizi-online/statistica-self-service-1).

Tabella 1 - Popolazioni target per Area disciplinare e Distretto nella Provincia di Parma- Anno 2020

Distretto Socio Sanitario	NPIA			PA			DP		
	0-17	**Δ%**	**% S**	**>18**	**Δ%**	**% S**	**15-64**	**Δ%**	**% S**
Parma	35.839	-0,05	22,9	191.935	0	16,1	148.185	0,3	20,3
Fidenza	16.849	-0,05	20	87.637	0	12,6	66.085	0,3	16,2
Valli Taro e Ceno	6.093	-0,2	17	37.736	-0,06	8,9	26.147	-0,6	12,2
Sud Est	12.630	0	18,7	64.805	-0,02	12	49.110	0,1	15,3
AUSL	**71.411**	**-0,3**	**21**	**382.113**	**-0,1**	**13,9**	**289.527**	0,2	17,8

Δ%: variazione percentuale rispetto all'anno precedente; % S: percentuale di stranieri

Dai dati demografici mostrati in tabella si può osservare che, sebbene con alcune differenze distrettuali, le popolazioni *target* delle diverse aree disciplinari hanno subito, per la prima volta da anni, una lievissima flessione, più accentuata nei distretti Valli Taro e Ceno e Sud Est.

Si segnala che, nonostante la lieve diminuzione della popolazione residente, la percentuale degli stranieri e' comunque aumentata in termini percentuali (+ 0,5 nel target NPIA e +0,3 nel segmento SMA)

Nella tabella 2 i dati in valori assoluti riguardanti il numero di persone con almeno una prestazione effettuata nell'anno 2020, a prescindere da età e residenza. Complessivamente si tratta di 15.581 persone.

Tabella 2 - Numero di utenti con almeno una prestazione nell'anno per area disciplinare- Anno 2020

Distretto	NPIA	PA*	DP
Parma	2655	3721	1522
Fidenza	1433	1431	633
Valli Taro e Ceno	536	820	304
Sud Est	1072	1099	355
AUSL	**5696**	**7071**	**2814**

**A seguito del passaggio alla nuova cartella Unica Regionale informatizzata, i dati sono relativi alle attivita' svolte fino al 13/11/2020*

Se nella precedente tabella si sono conteggiati tutti gli utenti che hanno avuto almeno un accesso nei servizi del Dipartimento, nelle successive tabelle 3, 4 e 5 si sono conteggiati solo gli utenti residenti e di cittadinanza straniera coerenti con le età target di ognuna delle aree,suddivisi per Distretto. Nella prima colonna viene riportato il numero di persone residenti che hanno usufruito di almeno una prestazione e che rientrano nel *range* della popolazione target (definiti *utenti target*), nella seconda colonna la variazione percentuale rispetto all'anno precedente, mentre nella terza colonna il rapporto tra utenti target e popolazione di riferimento (tasso d'accesso). La quarta e quinta colonna sono riportati gli stessi dati riferiti alla popolazione straniera residente.

Tabella 3 - Rapporto utenti con accesso e popolazione target in NPIA per Distretto: italiani e stranieri. Anno 2020

	N°utenti target[1]	Δ% 2020-2019	N utenti/ Pop. target*1000	N stranieri [2]	N stranieri/ Pop. target*1000
Parma	2396	-8,4	66,8	637	77,8
Fidenza	1337	-3,9	81,7	345	101,9
Valli Taro e Ceno	490	-25,9	80,4	266	256,2
Sud Est	1010	-20,7	80	109	45,9
NPIA AUSL	5233	-11,9	73,2	1357	90,4

[1] utenti residenti, stranieri e senza fissa dimora con età compresa tra gli 0 e 17 anni.
[2] utenti stranieri residenti sul territorio con età compresa tra gli 0 e i 17 anni

Ovviamente il periodi di chiusura di molte attività durante il periodo di lockdown restituisce un dato di difficile lettura in merito alla prevalenza. E' interessante comunque notare che il calo e'piu' contenuto a Parma e a Fidenza mentre nei distretti piu' periferici risulta piu'evidente. Laprevalenza di stranieri visti per 1000 stranieri minori residenti, pur risultando complessivamente stabile, segna un dato senza precedenti nel distretto Valli Taro e Ceno, in assoluta controtendenza rispetto al dato del Sud Est.

Tabella 4 - Rapporto utenti con accesso e popolazione target in PA per Distretto: italiani e stranieri. Anno 2020*

	N°utenti target[1]	Δ% 2020-2019	N utenti/ Pop. target*1000	N stranieri [2]	N stranieri/ Pop. target*1000
Parma	3519	-18,8	18,3	313	10,1
Fidenza	1395	-9,3	15,9	116	10,4
Valli Taro e Ceno	800	-15	21,1	54	16
Sud Est	1078	-16.9	16,6	82	10,4
PA AUSL	6792	-16,3	17,7	565	10,6

[1] utenti residenti, stranieri senza fissa dimora con età ≥ 18 anni.
[2] utenti stranieri residenti sul territorio con età con età ≥ 18 anni

**A seguito del passaggio alla nuova cartella Unica Regionale informatizzata, i dati sono relativi alle attivita' svolte fino al 13/11/2020*

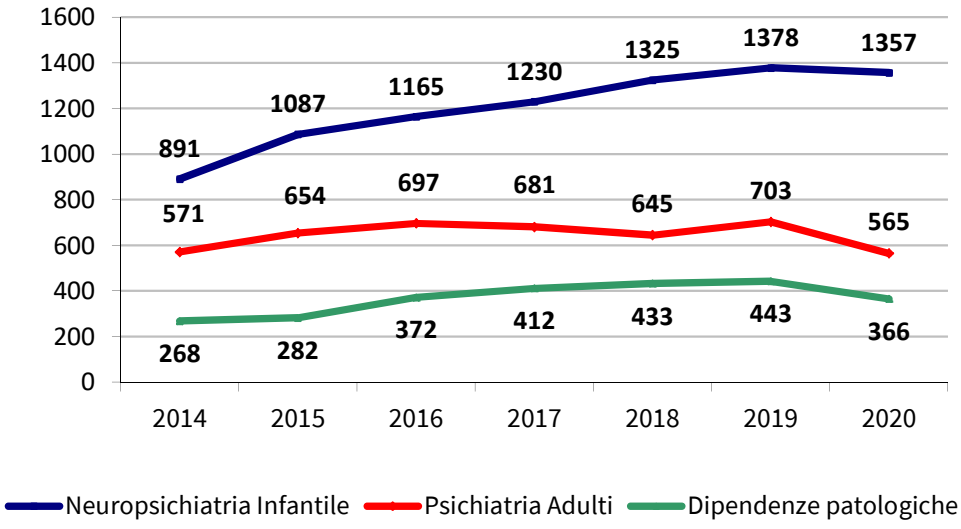
Tabella 5 - Rapporto utenti con accesso e popolazione target nelle DP per Distretto: italiani e stranieri. Anno 2020

	N°utenti target[1]	Δ% 2019-2018	N utenti/ Pop. target*1000	N stranieri[2]	N stranieri/ Pop. target*1000
Parma	1314	-9,6	8,9	184	6,1
Fidenza	529	-20,9	8,0	63	5,9
Valli Taro e Ceno	242	-16,3	9,3	20	6,3
Sud Est	301	-15,4	6,1	43	5,7
DP AUSL	2386	-13,8	8,2	310	6,0

[1] utenti residenti, stranieri senza fissa dimora,con età compresa tra gli 15 e 64 anni.
[2] utenti stranieri residenti sul territorio o senza fissa dimora, con età compresa tra gli 15 e i 64 anni

Il tasso di accesso ai Servizi per le Dipendenze (tabella 5) nel 2020 si attesta su 8,2 individui ogni 1000 abitanti, dato leggermente inferiore all'anno precedente (9,6per 1000 abitanti) e seppure con entità diverse riguarda tutti i Distretti. Osservando lo stesso tasso, calcolato per l'utenza straniera si osserva anche in questo caso, una diminuzione di utilizzo dei Servizi che rimane di 6,0per 1.000 residenti stranieri nel 2019era 7,9. .La figura 1. riporta il *trend* storico dell'utenza straniera, in valori assoluti (residente e non),che afferisce ai Servizi del DAI-SMDP.

Figura 1- Serie storica utenti stranieri con accesso. Anni 2014-2020 (v.a.)



Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza

Nel 2020, in relazione alla pandemia da Covid, la NPIA ha rimodulato gli accessi e assicurato la continuità di cura anche con interventi di telemedicina e tele riabilitazione e la collaborazioni con Fondazione "Bambini e Autismo", Fondazione "Don Gnocchi", Ospedale privato "Maria Luigia", Cooperazione Sociale, Pediatri, la scuola, i Servizi Sociali e l'Autorità giudiziaria. In tutti i distretti sono stati sottoscritti i protocolli in applicazione della DGR 1102/2014 relativa alla tutela minori. I tempi di attesa rappresentano una criticità e nel 2020 si è perseguito il miglioramento dell'appropriatezza dei percorsi ed implementato, oltre al sistema di accesso tramite CUP, quello ad invio diretto del Pediatra per l'attivazione dei diversi percorsi formalizzati (percorso 0-3 anni, Autismo, ADHD, percorsi giudiziari, protocollo con Servizi Sociali).

I dati di attività mostrano una flessione nel primo semestre ed un recupero nel secondo, raggiungendo o superando di poco i livelli del 2019. In questa sezione vengono presentati i dati riferiti a pazienti seguiti con Progetto terapeutico riabilitativo dalla NPIA.

Tabella n. 6: Pazienti trattati 2020 per semestre per Distretto

	Parma	Fidenza	Sud-Est	Valli Taro-Ceno	Totale
Primo semestre	1906	963	804	389	**4062**
Secondo semestre	2093	1073	815	432	**4413**

Tabella 7 - Raffronto 2017/2020: pazienti in carico per Distretto

Distretto socio sanitario	2017		2018		2019		2020		Δ% 2020/2019	
	totale	nuovi	totale	nuovi	totale	nuovi	totale	nuovi	totale	nuovi
PARMA	1776	447	1957	362	1875	299	1452	332	-22,5	11
FIDENZA	794	185	917	128	839	61	685	113	-18,3	85
V. TARO E CENO	475	109	540	97	483	59	365	91	-24,4	54
SUD-EST	727	189	872	166	805	93	603	96	-25	3
TOTALE	**3772**	**930**	**4286**	**753**	**4002**	**512**	**3105**	**632**	**-22,4%**	**23,4%**

La distribuzione delle classi d'età mostrata in tabella 8 ribadisce la netta preponderanza dei casi seguiti in età scolare (6-13 anni).

Tabella 8 - Raffronto classi d'età- Pazienti in carico 2017 - 2020

Classi d'età	2017		2018		2019		2020	
	n	%	n	%	n	%	n	%
0-2	112	3,0	138	3,2	143	3,6	115	3,7
3-5	590	15,6	723	16,9	660	16,5	479	15,4
6-10	1382	36,6	1524	35,6	1460	36,5	1124	36,2
11-13	665	17,6	787	18,4	689	17,2	522	16,8
14-17	724	19,2	804	18,8	765	19,1	595	19,2
>18	299	7,9	310	7,2	285	7,1	270	8,7
Totale	**3772**	**100**	**4286**	**100**	**4002**	**100**	**3105**	**100%**

In continuità con gli anni precedenti, i pazienti in cura sono costituiti dal 63,9% di maschi, mentre le femmine sono il 36,1%.Prosegue, in linea con i cambiamenti demografici,la crescita della componente di stranieri in carico alle strutture NPIA.Nellatab. 9 si rileva un incremento della percentuale di stranieri.

Tabella 9 - Raffronto pazientiin carico per cittadinanza

	2017	2018	2019	2020
Stranieri	704	863	886	748
% stranieri sul tot.	18,7	20,1	22,1	24,1

Nella tabella 10 sono riportati i dati relativi alle diagnosi, a tal proposito si ricorda che la classificazione diagnostica adottata dalla NPIA è quella dell'ICD-10 e che le categorie diagnostiche non sono mutualmente esclusive, per cui uno stesso paziente può avere ricevuto più di una diagnosi.

Tabella 10 - Diagnosi in cartella pazienti in carico

Asse		2017	2018	2019	2020
1	**Disturbi dello sviluppo psichico**	1613	1051	2060	1581
	%	27,4	25,8	26,2	27,8
di cui	F 84 Disturbi evolutivi globali (Spettro Autistico)	265	236	366	385
	F 90 Disturbi ipercinetici	177	123	215	149
	F 92 Disturbi misti della condotta e sfera emozionale	202	132	295	206
2	**Disturbi Specifici dello sviluppo**	2019	1714	2432	1561
	%	34,3	42,1	31	27,5
di cui:	F80 (disturbi del linguaggio)	1117	927	1265	851
	F81 (disturbi dell'apprendimento)	784	731	1005	617
3	**Ritardo Mentale**	807	441	1015	761
	%	13,7	10,8	12,9	13,4
4	**Patologie neurologiche e/o malformative, neurosensoriali**	862	505	1147	921
	%	14,6	12,4	14,6	16,2
5	**Fattori influenzanti lo stato di salute e il ricorso ai servizi sanitari (codici Z)**	589	340	1195	862
	%	10,0	8,9	15,2	15,2

Disturbi Specifici di Apprendimento.

Anche nel 2020 sono proseguite, con 12 incontri, le attività della Commissione per la diagnosi di conformità.

Le diagnosi di DSA effettuate da specialisti privati valutate dalla Commissione sono state 170, delle quali 152 sono state validate in prima istanza e 8 in seconda istanza.

Le diagnosi nell'ambito del giovane adulto sono state 19, di cui 18 ritenute conformi e una non conforme.

Percorso 0-3 anni

L'attività dedicata alla fascia di età 0-3 anni è prevalentemente indirizzata a patologie di tipo neurologico (Paralisi cerebrali infantili, patologie genetiche e cromosomiche, esiti di prematuranza).

Tabella 11 - Diagnosi percorso 0-3anni

Asse	Definizione ICD-10	2017		2018		2019		2020	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1	Disturbi dello sviluppo psichico	47	16,4	38	14,8	58	14,6	41	14,9
2	Disturbi evolutivi specifici	73	25,4	62	24	95	24	43	15,6
3	Ritardo mentale	16	5,5	7	2,7	28	7	19	6,9
4	Patologie neurologiche, malformative, neurosensoriali	152	52,7	138	53,5	214	54,4	159	57,8
Totale diagnosi		**288**	**100**	**258**	**100**	**395**	**100**	**262**	**100**

Nel corso del 2020 l'andamento è di sostanziale conferma rispetto agli anni precedenti. È attivo dal 2012 un percorso interaziendale per la presa in carico precoce delle Disabilità Uditive individuate grazie allo screening neonatale uditivo effettuato in tutti i punti nascita della provincia.

Percorso di cura e tutela minori

I minori collocati al di fuori della famiglia di origine per tutela e cura, costituiscono un gruppo di persone che va attentamente seguito in quanto si tratta situazioni assai delicate sotto diversi profili giuridico, etico, educativo, sanitario e sociale. Dal marzo 2013, è stato attivato un Cruscotto dedicato con lo scopo di monitorare tutti i percorsi e facilitare, d'intesa con gli Enti Locali la prevenzione e la ricerca di soluzioni alternative come previsto dalla Regione Emilia Romagna. Il Cruscotto registra tutti i minori allontanati che sono seguiti dalla UOC di NPIA esono considerati "casi complessi" ai sensi della DGR 1102/2014.

In tabella 12 è riportato il numero dei minori collocati al di fuori della famiglia considerati "casi complessi".

Tabella 12 - N. Collocazioni extrafamiliari 2015-2020

	Parma	Sud Est	Valli Taro e Ceno	Fidenza	Totale
Gennaio 2015	11	6	2	4	**23**
Gennaio 2016	13	8	1	4	**26**
Febbraio 2017	19	10	4	5	**37**
Dicembre 2017	21	9	3	6	**39**
Dicembre 2018	24	6	3	6	**39**
Dicembre 2019	29	7	5	7	**48**
Dicembre 2020	40	9	3	9	**61**

Vi è stato un incremento del numero di nuovi inserimenti negli ultimi 5 anni, da un numero complessivo di 23 nel 2015 sono passati a 61 nel 2020 con un incremento 2019-2020 del 27%, ancor maggiore se riferito al Distretto di Parma. Si è posta una maggiore attenzione al monitoraggio del percorso terapeutico-riabilitativo.Si segnala che, dei 61 casi in oggetto, 24 hanno un'età superiore ai 17 anni.

Residenze per Minori di San Polo di Torrile

La RTI-Minori di S. Polo di Torrile ha come riferimento l'Area Vasta Emilia Nord, comprensiva, oltre a Parma, delle provincie di Piacenza, Reggio Emilia e Modena.Nel 2020 l'attività della RTI M è stata condizionata dal Covid che ha comportato una sospensione degli accessi nel periodo marzo-aprile e una riduzione della capienza a 6 letti, al fine di migliorare il distanziamento. Pur con questi limiti i Trattamenti Intensivi sono stati 37 e hanno generato 851 giornate in favore di 32 pazienti, con una degenza media di 23 giorni.

Tabella n. 13: RTI-P/M San Polo di Torrile. Anni 2016-2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Ricoveri totali	62	72	66	61	58
Ricoveri in RTI	34	46	45	42	37
Ricoveri in RTP	28	26	21	19	21

I ricoveri sono così suddivisi per provenienza:

Tabella n. 14: Ricoveri di minori per Trattamenti Intensivi. Anno 2020

Ausl di Parma	25 ricoveri che hanno generato 593 giornate in favore di 22 pazienti
Ausl di Piacenza	7 ricoveri che hanno generato 150 giornate in favore di 7 pazienti
Ausl di Reggio Emilia	1 ricovero che ha generato 16 giornate
Ausl di Modena	3 ricoveri che hanno generato 61 giornate in favore di 2 pazienti
Extra RER	1 ricovero che ha generato 31 giornate

I Trattamenti Post acuzie (protratti) sono stati 21, per un totale di 808 giornate in favore di 21 pazienti e con una degenza media calcolata di 38,8 giorni/ricovero. I ricoveri sono così suddivisi per provenienza

Tabella n. 15: Ricoveri per Trattamenti Post acuzie protratti. Anno 2020

Ausl di Parma	17 ricoveri che hanno generato 696 giornate in favore di 17 pazienti
Ausl di Piacenza	2 ricoveri che hanno generato 46 giornate in favore di 2 pazienti
Ausl di Reggio Emilia	2 ricoveri che hanno generato 67 giornate in favore di 2 pazienti

Psichiatria Adulti

Nella presente sezione vengono presentati i principali dati relativi ai pazienti in carico (ossia con un progetto terapeutico aperto nell'anno) nei Centri di Salute Mentale, inseriti nel Sistema Residenziale, seguiti con progetti personalizzati con Budget di Salute o trattati nell'Area Ospedaliera.

I Centri di Salute Mentale (CSM)

Accessi e Programma "Leggieri"

Nel 2020, a seguito della pandemia da Covid19,il DAI-SMDP ha modificato le funzioni di consultazione-consulenza al Dipartimento di Cure Primarie, assicurando l'attività di E-U e di continuità di cura, anche mediante la telepsichiatria e il potenziamento delle visite domiciliari.

L'attività di collaborazione con i Medici di Medicina Generale "Programma Leggieri" è proseguita seppure con una riduzione dell'attività presso le Case della Salute, ed ha prodotto 1613 Consulenze di cui 563 sono esitate in episodi di cura condivisi. Si è altresì affiancato in via sperimentale un Servizio di Consultazione-Consulenza ai Medici di Medicina Generale che, solo nel distretto di Parma, ove è stato effettuato una rilevazione specifica, ha prodotto 647 interventi di supporto (383 consultazioni e 264 consulenze, metà delle quali tramite mezzi a distanza).

Il numero degli MMG coinvolti in questo sistema di supporto è stato, nel solo distretto di Parma, di ben 141. Quindi seppure in forma diversa, con un positivo incremento della Consultazione, l'attività complessiva del Programma è in linea con quella degli anni precedenti.

Attività Territoriale

Nell'ambito delle attività svolte dai Servizi della Salute Mentale Adulti, nel corso dell'anno 2020 rispetto al 2019 si è registrata una riduzione nel primo semestre, mentre nel secondo i livelli sono risultati sostanzialmente sovrapponibili a quelli dell'anno precedente. Il numero dei pazienti assistiti dai Centri di Salute Mentale si è mantenuto sui livelli elevati raggiunti negli ultimi quattro anni, dimostrando che, pur nella pandemia, i servizi hanno avuto una loro "tenuta"

Tabella n. 16: LEA Territoriale - Centri di salute mentale. Pazienti trattati Anno 2020 per semestre

	Parma	Fidenza	Sud-Est	Valli Taro-Ceno	Totale
Primo semestre	3416	1290	1133	719	**6558**
Secondo semestre	3822	1598	1094	761	**7275**

Tabella n. 17: LEA Territoriale - Centri di salute mentale. Pazienti trattati Anno 2019 per semestre

	Parma	Fidenza	Sud-Est	Valli Taro-Ceno	Totale
Primo semestre	3938	1359	1292	786	**7375**
Secondo semestre	3798	1360	1319	787	**7264**

Tabella 18 - Pazienti in carico PA- Anni 2017-2020 Totale e nuovi.

Unità Operativa	2017		2018		2019		2020		Δ% 2020-19	
	totale	nuovi	totale	nuovi	totale	nuovi	totale	nuovi	Totale	nuovi
CSM Parma Est	1053	131	1076	120	1055	84	911	76	-13,6	-9,5
CSM Parma Nord	485	76	487	60	418	37	399	29	-4,5	-21,6
CSM Parma Ovest	835	118	841	83	827	76	839	60	2,6	-21
Centro Adolescenza *(> 18 anni)*	77	28	63	19	64	32	47	13	-26	-59
Ambulatori Clinica Psichiatrica	629	138	672	153	638	115	612	97	-4	-15,6
CSM Fidenza	1337	174	1377	140	1320	115	1371	123	3,8	6,9
CSM Sud-Est	1010	159	978	106	1007	124	911	84	-9,5	-32
CSM Valli Taro E Ceno	799	150	775	128	731	107	654	73	-10,5	-31
Totale	**6225**	**974**	**6270**	**809**	**6061**	**690**	**5816**	**555**	**-4**	**-19,5%**

Tabella 19 - Classi di età pazienti in carico PA. Anni 2017-2020

Classi di età	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%
<18	40	0,6	45	0,7	25	0,4	6	0,1
18-29	704	11,3	757	12,1	703	11,6	697	11,9
30-39	755	12,1	752	12	728	12	670	11,5
40-49	1310	21,0	1247	19,9	1167	19,3	1116	19,1
50-59	1460	23,5	1490	23,8	1470	24,3	1430	24,5
60-69	1008	16,2	1021	16,3	1035	17,1	1022	17,5
70-79	667	10,7	662	10,6	657	10,8	614	10,5
>80	281	4,5	296	4,7	276	4,6	261	4,4
Totale	6225	100	6270	100	6061	100	5816	100

Tabella 20 -Diagnosi Principale. Anno 2017-2020 (%)

Diagnosi (codice ICD 9 CM)	2017	2018	2019	2020
Stati psicotici organici (290/294)	220	217	208	188
Psicosi schizofrenica (295)	890	855	843	844
Psicosi affettiva (296)	1555	1504	1434	1423
Altri stati psicotici non organici (297/299)	529	557	523	564
Disturbi neurotici (300)	790	796	724	717
Disturbi di personalità (301)	741	769	749	703
Dipendenze da sostanze (303/305)	44	46	48	41
Disturbi alimentari (307)	193	204	210	168
Depressioni e reazioni di adattamento (308/309/311)	952	991	958	835
Disturbi della condotta (312)	68	64	54	47
Ritardo mentale (317/318)	137	161	135	147
Disturbi mentali NAS (V40)	19	21	11	2
Altre diagnosi	87	85	164	137
Totale	**6.225**	**6.270**	**6061**	**5816**

Residenze e Budget di Salute

Residenze a Trattamento Intensivo (RTI)

I dati delle Residenze a Trattamento Intensivo devono tenere conto della riduzione dei posti e del funzionamento da marzo a giugno 2020, come reparto Covid, della RTI Presidio Residenziale Psichiatrico di Fidenza. L'attività a sostegno dei programmi territoriali e domiciliari ha portato allo sviluppo del PDTA della Multicomplessità.

Nel 2020 si rileva una riduzione delle giornate complessive mentre la degenza media e complessiva sono aumentati in relazione alla maggiore gravità, complessità e multi problematicità delle situazioni cliniche e di vita delle persone che accedono al sistema residenziale (condizioni di solitudine, assenza di familiari, stati di abbandono e povertà estrema, situazioni connesse a misure giudiziarie, migrazioni, assenza di fissa dimora, mancanza di documenti).

Tabella n. 21: Residenze RTI Territoriali. Anni 2015-2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Posti	30	30	30	30	30
Ricoveri	359	370	278	189	92
Degenza complessiva (gg)	9238	8989	7704	6919	4292
Degenza media (gg)	26	24	27,7	36,6	46,6

Residenze Sanitarie a Trattamento Estensivo (RTE)

La Residenzialità Sanitaria Estensiva riguarda le residenze territoriali a trattamento protratto e socio-riabilitativo.

Mentre la Residenzialità di tipo Intensivo rientra nel circuito dell'Emergenza Urgenza e dell'attività territoriale, la forma di residenzialità sanitaria di tipo Estensivo è funzionalmente vicina a quella socio-sanitaria.

Tabella n. 22: Residenze Sanitarie a Trattamento Estensivo. Anno 2020

	2017	2018	2019	2020	Ingressi 2020	Dimissioni 2020
RTE I° Maggio	9	10	10	7	3	6
RTE Vigheffio	11	11	10	10	3	3
RTP Villino	19	19	18	19	3	2
Totale	**39**	**40**	**38**	**36**	**9**	**11**

Nelle residenze sanitarie estensive si è realizzato un turn-over del 27,7%, superiore a quello dell'anno precedente e coerente con il mandato di struttura .

Residenzialità socio-sanitaria e Budget di Salute

La residenzialità socio-sanitaria comprende strutture quali le Comunità Alloggio e i Gruppi Appartamento.

Sono stati evidenziati a parte gli Alloggi collegati ad altre strutture o collocati funzionalmente in prossimità di esse. Vengono poi riportati gli alloggi a disposizione dei servizi territoriali, una tipologia di risorsa che può consentire l'inserimento degli utenti con Budget di Salute.

Tabella 23 - Dettaglio strutture sociosanitarie, numero di pazienti nell'anno

	2017	2018	2019	2020	Ingressi 2020	Dimissioni 2020
Comunità Alloggio						
CA Appennino	17	18	18	17	1	2
CA Casamica	14	14	13	14	1	0
CA Villa Mamiani	7	7	7	6	2	3
Totale	**38**	**39**	**38**	**37**	**4**	**5**
Gruppi Appartamento						
GA Ticchiano	6	6	6	6	0	0
GA Pontetaro	5+1	6+1	6+1	6+1	0	0
GA Vigheffio	6	6	5	6	1	0
GA Corsini	6+6	6+6	4+6	5+6	2	1
Totale	**30**	**31**	**28**	**30**	**3**	**1**
Gruppi di Convivenza						
viaCocconcelli	5	5	4	3	0	0
via Verona (ex via Solferino)	6	4	4	4	2	2
Totale	**11**	**9**	**8**	**7**	**2**	**2**

Alloggi e GA collegati a residenze						
Alloggi media/bassa protezione Pellegrino	4	3	4	3	1	2
GA Dopo di noi (ICE)	2	2	2	2	0	0
Appartamentini Colorno	8	8	8	8	5	5
GA Fidenza	6	6	6	6	0	0
GA Armonia Felino	5	5	5	5	0	0
Totale	**25**	**24**	**26**	**24**	**6**	**7**

Tabella 24 - Riepilogo Strutture sociosanitarie, numero di pazienti nell'anno

	2017	**2018**	**2019**	**2020**	**Ingressi 2020**	**Dimissioni 2020**
Comunità alloggio	38	39	38	37	4	5
Gruppi appartamento	30	31	28	30	3	1
Gruppi di convivenza	11	9	8	7	2	3
Alloggi e appartamenti collegati	25	24	25	24	3	4
Totale	**104**	**103**	**99**	**98**	**12**	**13**

Nel corso del 2020 sono pervenute al cruscotto 31 segnalazioni da parte dei servizi territoriali per inserimenti in strutture residenziali; 21 persone sono state inserite presso strutture residenziali mentre per gli altri utenti segnalati,in carico ai servizi territoriali,si è pervenuti alla ridefinizione di una progettualità maggiormente adeguata.

I dati del segmento socio-sanitario sembrano indicare un turnover complessivo del 13,26%, coerente con l'approccio finalizzato a dare prospettive evolutive all'utenza lungodegente secondo i principi dellarecovery, oltre a perseguire un'appropriata ricollocazione degli utenti, anziani e disabili. Una parte della rete socio-sanitaria deve essere riconvertita in risorse di comunità, anche mediante Budget di Salute, per fare fronte ai nuovi bisogni, quali giovani utenti e soggetti con disturbi del neurosviluppo.

Progetti terapeutico riabilitativi con Budget di Salute e Inserimenti lavorativi

I Progetti terapeutico-riabilitativi individualizzati con Budget di Salute sono in progressivo incremento, in applicazione alla Delibera 1554/2015, secondo quanto stabilito dalle direttive Regionale ed Aziendale e condiviso in sede di tavolo regionale "Programma per l'Autonomia possibile e Budget di Salute".

Nel corso del 2020 sono pervenute al cruscotto 49 segnalazioni da parte dei servizi territoriali per l'attivazione di un progetto Budget di salute. Tali richieste sono state oggetto di valutazione e di confronto tra il Responsabile del Cruscotto Budget di Salute e l'équipe multiprofessionale del CSM di riferimento, in sede di coordinamento dei progetti integrati ad alta complessità. Sono stati attivati 32 progetti con Budget di Salute, 5 verranno attivati nel 2021, mentre 12richiestesono state re-indirizzate verso nuove progettualità maggiormente idonee e rispondenti ai bisogni della persona.

Tabella 25 -: Assi di intervento progetti Budget di salute. Anno 2020

Lavoro/socialità	Domiciliarità	Domiciliarità/socialità	Domiciliarità/lavoro	Socialità	Totale
33	26	28	3	11	**101**
8	5	5	0	1	**19**
23	5	0	0	0	**28**
1	4	12	3	5	**25**
65	**40**	**45**	**6**	**17**	**173**

I Budget di Salute, rispetto al dato dello scorso anno, passano da 158 a 173.

Nella tabella viene riportato l'andamento nel tempo dei progetti con Budget di Salute in relazione agli affidamenti nel periodo 2015-20.

Tabella n. 26: Budget di salute: assegnazioni ex gara 2015-2020

	Consorzio Zenit	Consorzio Solidarietà sociale	Aurora Domus	Consorzio Fantasia	Altri	Totale
2015	31	40	13	8	9	**101**
2016	28	45	19	11	9	**112**
2017	25	49	18	11	13	**116**
2018	29	66	16	10	14	**135**
2019	40	73	20	12	13	**158**
2020	43	81	24	14	11	**173**

Alloggi assistiti

Al 31/12/2020 sono presenti 35 alloggi a disposizione dei CSM per un totale di 40 utenti inseriti; al momento rimangono disponibili5 posti.

Il sistema degli alloggi è a disposizione per percorsi riabilitativi rivolti alla recovery. La fruizione dell'intervento tuttavia, anche se sottoposta ad attenta valutazione, può essere temporaneamente connessa anche a fattori esterni al percorso di cura e inerenti i diritti di cittadinanza (mancata assegnazione alloggi ACER, povertà estrema ed al.).

Interventi psicosociali /Attività' Riabilitative /Gruppi di Auto Mutuo Aiuto (AMA)

Interventi Psicosociali

L'attività presso la struttura semiresidenziale del DAI SM- DP è stata riorganizzata secondo il modello del Centro Diurno "Diffuso", realizzando un incremento significativo del numero di interventi domiciliari e sul territorio, sulla base di progetti individualizzati che hanno coinvolto pazienti dei CSM, mentre è stato ridotto il numero di pazienti destinatari di interventi gruppali in sede. Le attività di questo segmento sono sempre più integrate a progetti innovativi quali Budget di Salute, Auto Mutuo Aiuto, Individual Placement Support (IPS) ed alle attività riabilitative sportive ed espressive.

I gruppi di Auto Mutuo Aiuto hanno assunto all'interno del nostro Servizio e della realtà comunitaria locale, un rilievo crescente. Diverse patologie, stati di disagio e problemi quotidiani, vengono sempre più affrontati dal basso, facendo leva sulle motivazioni, l'interesse e le esperienze delle persone direttamente coinvolte, affiancando la presa in carico di professionisti e dell'Istituzione. Ciò ha portato a sviluppi impensabili per molte iniziative degli individui che vogliono concorrere in modo attivo al mantenimento e/o al monitoraggio della propria salute. Quello che indicano la letteratura internazionale e l'esperienza di molti attori del mondo della Salute Mentale è che, dal punto di vista dei Servizi, conoscere la prospettiva di chi ne fruisce, è fondamentale per proporre interventi efficaci e di qualità.

Nel DAI-SMDP sono attivi numerosi gruppi gestiti anche da Associazioni e Cooperative(Avalon "Autoscuola" e Cabiria). Alcune esperienze si sono concluse altre sono state avviate. Ne facciamo menzione in modo più dettagliato nella tabellan.27.Dall'inizio dell'anno è stato completato il primo corso di formazione per facilitatori sociali/orientatori sociali.

Nel 2020 in relazione alla pandemia si sono effettuati Gruppi a distanza, sedute all'aperto, modalità di collaborazione innovative.

Tabella 27–Attività e convolti Gruppi Autoaiuto

Denominazione	Incontri	Operatori	Partecipanti	Volontari
Quelli che l'AMA	38	3	37	5
Associazione Itaca	30	2	16	2
Centro Diurno Santi	20	7	15	
Diagnosi e Cura	27	5	80	
REMS	8	9	7	
Totale	**123**	**26**	**120**	**7**

Attività Ospedaliera

Nell'Area dell'Emergenza-Urgenza i percorsi prevedono la collaborazione con i Pronto Soccorso di Parma e Fidenza, con l'Ospedale privato accreditato"Maria Luigia", con la rete dei CSM-Residenze, Servizio 118 e di continuità assistenziale e le Polizie Municipali in caso di TSO. Nella tabella 28 sono riportati i principali dati d'attività del **Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura (SPDC)** che nel 2020 per la pandemia,al fine di assicurare il distanziamento, ha avuto una rimodulazione della dotazione dei posti.

Servizi Psichiatrici Ospedalieri

Nell'Area delle E-U i consolidati percorsi con il PS dell'AOU, con l'Ospedale privato accreditato "Maria Luigia" e con la rete dei CSM-Residenze hanno risentito fortemente delle modificazioni della dotazione dei posti per l'emergenza Covid, al fine di assicurare il necessario distanziamento. Infatti il SPDC è passato prima a 9 posti, poi a 11 e da ottobre 2020 a 13; marzo 2020 lo SPOI è passato a 11 posti e da settembre l'attività è stata rimodulata al fine di assicurare le "aree grigie" e l'assistenza presso il Covid Hospital.

I dati 2020 hanno accentuato un trend, in atto dal 2015, di riduzione del numero dei ricoveri (per SPDC

-26% dal 2020-2019), con un lieve incremento della degenza media. L'indice di occupazione si è mantenuto stabile.

Nel 2020 si è mantenuto un basso numero di contenzioni in totale (3 contro le 6 del 2019), avvicinandosi all'obiettivo di "contenzioni zero". Il numero di consulenze psichiatriche in PS e nei reparti di Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma si è stabilizzato nei volumi, mentre è migliorata la qualità delle richieste, nonché il lavoro congiunto su casi ad altissima complessità come ad esempio i soggetti affetti da DCA.

I dati relativi al segmento ospedaliero e residenziale indicano una riduzione del numero dei ricoveri ed un parallelo aumento della gravità/complessità dei casi trattati complessità, nonché delle difficoltà socio-ambientali.

Tabella n. 28: SPDC. Anni 2016-2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Ricoveri	491	462	421	339	250
di cui da altre province/regioni/non residenti	79	62	69	62	32
TSO totali	108	83	95	93	87
TSO durante ricovero	100	77	89	85	2
Contenzioni	20	14	5	6	3
Giornate di degenza tot.	5035	4999	5033	4712	3675
Degenza media	10	11	11,9	14,3	15,2
Presenza media giornaliera	13,7	13,8	13,8	12,9	10
Indice occupazione letti	91%	92%	92%	86%	83%

I dati evidenziano un trend, in atto dal 2014, di riduzione significativa del numero dei ricoveri e un incremento della degenza media in relazione ad una maggiore gravità/complessità dell'utenza. L'indice di occupazione è comunque risultato inferiore al 90%.

Il numero complessivo di consulenze psichiatriche in PS e nei reparti di Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma si è stabilizzato nei volumi, intorno ai 2500/ anno, mentre è migliorata la qualità delle richieste, nonché il lavoro congiunto su casi ad altissima complessità come ad esempio i soggetti affetti da DCA. Nella tabella 29 viene riportato il rapporto tra TSO dei residenti e popolazione residente nel periodo 2015-20.

Tabella 29- Rapporto TSO/popolazione residente. Anni 2015-2020

2015	2016	2017	2018	2019	2020
28.5	23,4	18,4	21,2	20,4	19,4

*Prevalenza *100.000 abitanti residenti sui residenti Ausl Parma in TSO in SPDC (tasso grezzo)*

Il **Servizio Psichiatrico Ospedaliero Intensivo (SPOI)**

Nel corso del 2020, per la pandemia ha visto rimodulate le attività prima con la riduzione dei letti a 11 e da settembre a 3 per assicurare "l'area grigia" e i percorsi di assistenza per il Covid,.

Tabella 30- Attività Servizio Psichiatrico Ospedaliero Intensivo (Clinica Psichiatrica)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ricoveri	401	372	353	337	309	148
Giornate di degenza	5.455	5.583	5.709	5.775	5160	2609
Degenza media (gg)	13,6	14,39	15,8	17,1	16,7	17,6
Indice occupazione posti letto	93,4	95,3	97,7	98,8	88,3	44,6
Consulenze in Reparti AOU	1424	1199	1197	1124	1192	983
Day Hospital	133	174	193	180	193	156

Ospedale Privato" Maria Luigia"
I dati dimostrano un impegno congiunto nel raggiungimento degli obiettivi del dipartimento e conferma la positiva gestione tramite il "Cruscotto".

Tabella n. 31: Degenze medie Ospedale Privato Accreditato Maria Luigia. Anni 2016-2020

	2016	2017	2018	2019	2020
SPOI (8 posti)	8,2 gg	9,4 gg	10,8 gg	8,7 gg	8,6 gg
RTI (10 posti)	27,7 gg	36,24 gg	37,7 gg	27,1 gg	41,8 gg
RTS DD (7 posti)	23,2 gg	18,21 gg	25,3 gg	22,9 gg	28,6 gg
RTS alcologia	23,4 gg	23,31 gg	24,3 gg	24,7 gg	29,8 gg
RTS DCA	38,8 gg	45 gg	27,2 gg	25,3 gg	35,7 gg
RTP	125,4 gg	88 gg	82,6 gg	46,8 gg	99 gg
Psicogeriatria (5 posti)	36,9 gg	46,76gg	51,11gg	35,9 gg	41,5 gg

Tabella n. 32: RicoveriOspedale Privato Accreditato Maria Luigia. Anni 2020

	Ricoveri
SPOI (8 posti)	301
RTI (10 posti)	148
RTS DD (7 posti)	60
RTS alcologia	35
RTS DCA	23
RTP	8
Psicogeriatria (5 posti)	33

Nella tabella 31 e 32 sono illustrati i dati di attività relativi ai diversi regimi di ricovero **dell'Ospedale Privato Accreditato "Maria Luigia".**I dati dimostrano un impegno congiunto nel raggiungimento degli obiettivi del dipartimento e conferma la positiva gestione tramite il "Cruscotto" per l'Emergenza-Urgenza per il pieno e appropriato utilizzo delle risorse: SPOI 8 posti; RTI 10 posti, RTS Specialistica Doppia Diagnosi 7 posti, RTS Alcologia 2 posti, RTP 5 posti, RTS Psicogeriatria 5 posti, RTS DCA 2 posti.

Si segnala una riduzione della degenza media in tutte le tipologie di offerta residenziale, nonostante la presenza di utenti con provvedimenti giudiziari.

.

Programmi / Percorsi

Lo sviluppo dei Programmi e dei Percorsi Diagnostici Terapeutici e Assistenziali(PDTA) implica la collaborazione di diverse Aree Disciplinari e Unità Operative del DAI-SMDP ma anche del Dipartimento Cure Primarie, dell'Ospedale.

Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA)

Dal2016 è attivo il PDTA interaziendale per i DCA e in tabella 33 sono riportati i dati 2017-20

Tabella 33 - Pazienti trattati dal Programma DCA. Anni 2017-2020

	2017	2018	2019	2020
Totale DCA	**192**	**145**	**150**	**209**

I dati sotto riportati nei grafici mostrano l'andamento nel corso degli ultimi tre anni ed appare significativo l'incremento della fascia 12-17 e 18-34 anni.

Figura 2 – Casi in carico DCA per classi di età

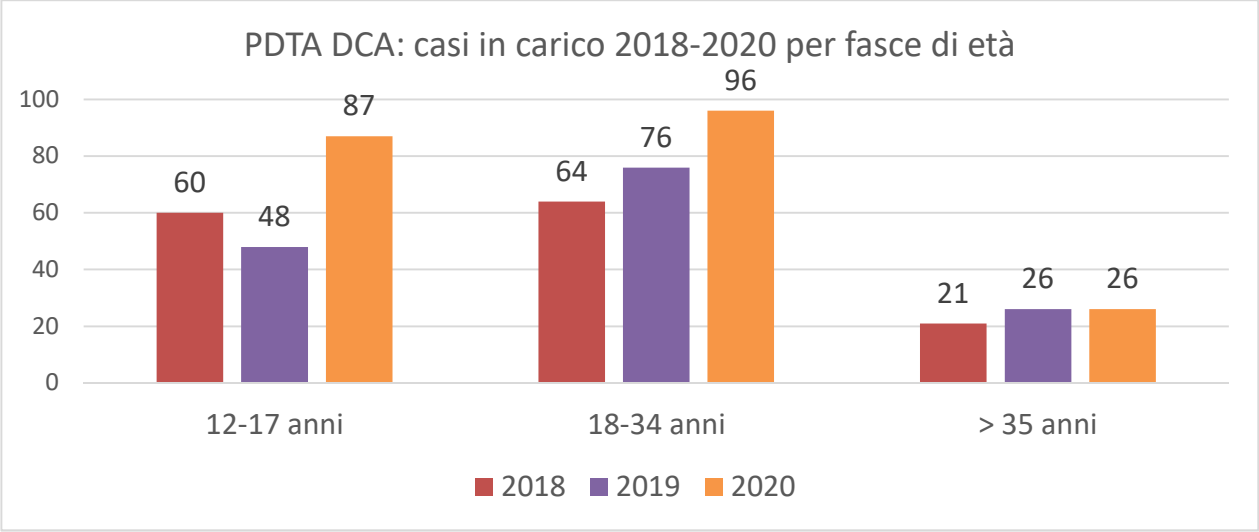
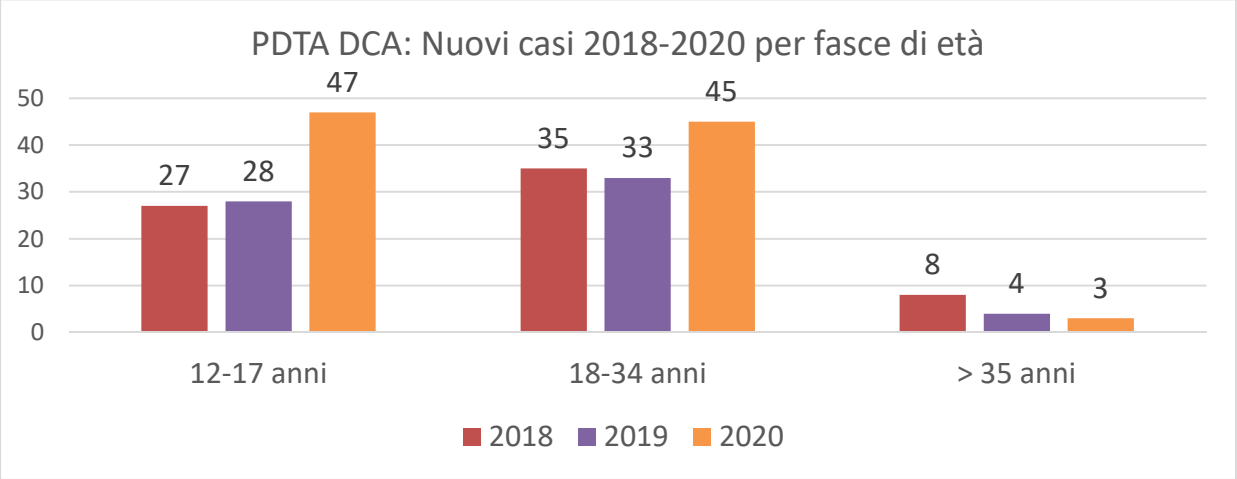


Figura 3 – Nuovi casi in carico DCA per classi di età



Malgrado la situazione pandemica, le attività del PDCA non sono mai state interrotte. Le visite psichiatriche, NPIA, psicologiche e nutrizionali sono continuate da remoto in situazioni non urgenti. L'attività di psicoeducazione per i familiari è proseguita da remoto tramite due cicli di psicoterapia di gruppo per familiari dei nuovi casi in età evolutiva, per un totale di 30 familiari trattati.

Il reparto di Clinica e Terapia Medica AOU è stato inoltre impegnato in 2 lunghi ricoveri (di 6 e 4 mesi/cad) di pazienti con grave AN in urgenza metabolica.

La attività infermieristica del PDCA è stata mantenuta ed è stata implementata in parte da remoto sotto forma di counselling telefonico per il monitoraggio ed il sostegno dei pazienti anche a distanza.

La seconda metà del 2020 ha visto un incremento nella incidenza di nuovi casi, nella quasi totalità con presentazione clinica di AN grave.

La situazione pandemica ha anche comportato difficoltà negli inserimenti in alcune strutture riabilitative: in alcuni casi la sospensione delle attività semiresidenziali ha comportato un ridotto turn-over dei pazienti in regime residenziale e dunque assenza di disponibilità di ricovero per nuovi pazienti anche gravi, che dunque rischiano di rimanere al livello ambulatoriale anche quando per loro inappropriato.

Percorso Esordi Psicotici

Il riconoscimento dei segnali precoci di rischio e l'attivazione dei relativi percorsi di cura, così come evidenziato dalla ricerca scientifica, si è dimostrato un approccio efficace nel migliorare gli esiti e la qualità di vita dei soggetti che evidenziano vulnerabilità psicotica (Alto Rischio ed esordi psicotici) o una situazione clinica di esordio psicotico.

Il DAISMDP dell'AUSL di Parma da diversi anni ha focalizzato l'attenzione sul tema degli Esordi Psicotici (EP) secondo lo specifico Programma della Regione Emilia Romagna ed ha formalizzato il Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziali (PDTA) Esordi Psicotici. Questo costituisce il modello più idoneo per la gestione clinico-organizzativa degli EP, in quanto considerato uno strumento maggiormente rispondente ai bisogni e alle risorse della persona. Il PDTA è applicato in tutte le articolazioni del DAI SM-DP, in collaborazione con il Dipartimento di Cure Primarie, con l'UOC di Psicologia Clinica, con il Pronto Soccorso dell'AOU di Parma e del Presidio Ospedaliero Aziendale, l'Ospedale Privato Accreditato "Maria Luigia" di Monticelli Terme (PR). I destinatari sono pazienti (nuovi casi), di ambo i sessi, di età compresa tra i 12 e i 54 anni, con sospetto o diagnosi di prima manifestazione psicotica per garantire, indipendentemente dall'accesso:

- una tempestiva intercettazione e accoglienza/valutazione interdisciplinare utile ad avviare rapidamente ed in modo adeguato il PDTA per tutti i nuovi casi/esordi sul territorio, secondo un modello diffuso; la riduzione della

variabilità nella valutazione iniziale e nel trattamento garantendo interventi specifici, appropriati che possano ridurre il più possibile la transizione verso la psicosi conclamata;

- riduzione del tempo intercorrente tra l'insorgenza di sintomi e/o segnali di allarme di soggetti EP ed Alto Rischio e conseguente presa in carico integrata da parte dei servizi territoriali finalizzata ad una recovery clinica, personale e sociale, riducendo lo stigma;fornire modalità empiricamente supportate di assistenza alle famiglie degli utenti;

-integrare gli interventi del PDTA con quelli forniti dalle associazioni presenti sul territorio e collaborare attivamente con le agenzie sociali ed educative;

- costruire una rete di prossimità con MMG/PLS, Servizi Sociali, scuole, volontariato ed privato sociale per migliorare l'individuazione precoce e la presa in carico assistenziale;

-incrementare le competenze dei professionisti della salute mentale, ma anche di servizi sociali ed educativi, di utenti, associazioni, volontariato e privato sociale;

- contribuire alle attività di formazione e ricerca.

Nella Tab. 33 si evidenzia un incremento dei pazienti intercettati e una secca diminuzione del periodo di Psicosi non trattata (DUP).

Tabella 34 - Esordi Psicotici - Anni 2018-2020

	2018	2019	2020
Pazienti in percorso Esordi	112	110	129
Periodo di Psicosi non trattata (DUP) in mesi	7	11,8	6
Uso di sostanze (casi incidenti)	38	26	32
Età adolescenza (15-24)	45	25	34

Dalla valutazione dei dati con gli obiettivi e le azioni di miglioramento messi in atto nell'anno si confermano:
-riduzione del periodo di psicosi non trattata (DUP al 2020 pari a 6 mesi in media);

-incremento del numero di adolescenti/giovani adulti con EP ed il concomitante utilizzo di sostanze;

-migliore identificazione ed accoglienza/valutazione utile ad avviare rapidamente ed in modo adeguato il PDTA per tutti i nuovi casi/esordi sul territorio, secondo un modello diffuso;

-riduzione del tempo intercorrente tra l'insorgenza di sintomi e/o segnali di allarme di soggetti EP ed Alto Rischio e conseguente presa in carico integrata da parte dei servizi territoriali finalizzata ad una recovery clinica, personale e sociale, riducendo lo stigma;

-iniziale, seppur ancora non pienamente sviluppata, integrazione degli interventi del PDTA con quelli forniti dal territorio in collaborazione con le agenzie sociali ed educative attraverso l'implementazione del modello BdS.

Programma Regionale Integrato Autismo (PRIA) /Disturbi dello Spettro Autistico (ASD)

Nel corso del 2020, l'emergenza sanitaria da Covid-19 ha imposto di rivedere gli strumenti dei progetti di cura per i ragazzi con ASD e di sperimentare nuove modalità per poter, in primis, essere d'aiuto alle famiglie nella gestione quotidiana della nuova routine che si veniva a delineare e, in secondo luogo, per poter portare avanti gli obiettivi di un intervento fino a quel momento sempre pensato e realizzato in presenza.

Con l'inizio dell'emergenza sanitaria, tutti i piani terapeutici hanno subito una variazione rispetto alle modalità e alle tipologie di interventi. In un primo periodo, l'intervento svolto a distanza è stato di tipo asincrono, non diretto con il paziente, ed ha consistito nel prendere contatti con le famiglie sia telefonicamente sia con lo strumento di posta elettronica, per svolgere principalmente intervento di *counselling* rispetto alla gestione e alla comprensione di una nuova realtà.

In questa fase si è fatta rete fra i servizi (scuole, servizi educativi, Ente Locale, soggetti Convenzionati,…) con l'obiettivo di fare sentire accolte le famiglie e con una funzione proattiva rispetto ad eventuali situazioni di criticità.

In un secondo periodo, oltre al monitoraggio telefonico delle situazioni con contatti maggiormente strutturati, è stata sperimentata una modalità di intervento a distanza di tipo diretto con il paziente, o sincrono, consistente in videochiamate con il bambino/ragazzo, in presenza del genitore

Di fondamentale importanza è stata la collaborazione della famiglia nel rendersi partecipe alle videosessioni e a alle indicazioni fornite.

Parallelamente alla rimodulazione delle attività nei Nostri Servizi per i minori si sono rimodulate le attività dei Servizi in Convenzione: Fondazione Bambini e Autismo e Kiriku declinando attività in presenza e attività in remoto.

Da fine maggio-inizio giugno con la graduale ripresa degli interventi in presenza (a partire dai bambini più piccoli e da quelle situazioni che non hanno potuto accedere alle videosessioni), c'è stata una graduale riduzione degli interventi in videosessione, sino alla completa rimessa in presenza di tutti gli interventi riabilitativi da settembre2020.

Prosegue ed è stata incrementata l'attività di parent training anche nella formula di attività da remoto mediate dai genitori. Rispetto al giovane adulto, sono stati individuati gli psichiatri referenti ASD nei Centri di Salute Mentale di tutti Distretti, ma non vi è la dotazione di personale dedicata in ogni CSM.

Tutti i pazienti ASD, in uscita dai percorsi in NPIA, a partire dai 17 anni, secondo specifica procedura, vengono valutati in UVM e viene assicurata la continuità di cura mediante la presa in carico dai CSM. Il Servizio Sociale competente per territorio viene attivato per le situazioni che necessitano di una progettazione sul FRNA.

I criteri di eleggibilità per i quali una persona al compimento del 18°anno di età viene presa in carico del CSM e dal Servizio sociale fanno riferimento al livello di funzionamento, al trattamento psicofarmacologico e al tipo di bisogni espressi dalla persona e dalla sua famiglia.

La pandemia, inoltre, ha rimarcato la maggiore fragilità dei sistemi chiusi e fortemente strutturati, rispetto ai percorsi più flessibili, costruiti nell'ambito dei contesti locali.

Analisi e riflessioni vanno fatte sulle famiglie e sui loro bisogni e le risorse, tenendo conto della loro composizione, provenienza, cultura e reddito ecc., in relazione ad un carico assistenziale di lunga durata. Questo rende utile il proseguimento dell'attività di partent supporting anche in età adulta.

Emerge sempre più pressante il bisogno di opportunità di sollievo per le famiglie (weekend, settimana di sollievo). A tal proposito in ogni Distretto, in co-progettazione con le Associazioni, il DAS e gli Enti Locali, si stanno elaborando progettazioni a sostegno dei caregiver e della situazione di emergenza pandemica. In particolare nel Distretto di Parma, sul tavolo dei Piani di Zona, è stato approvato il Progetto "Terzo Tempo" che prevede la realizzazione di weekend in cui un piccolo gruppo di giovani adulti con ASD possono implementare esperimentare autonomie personali e sociali. Con il CSS è attivo un tavolo di co-progettazione rispetto a supporti per le famiglie che si trovano in difficoltà a causa della situazione pandemica (Progetto "Attivi Subito").

Tabella 35 - Utenti PRIA per Distretto e classi d'età- Anno 2020.

Età in anni	PARMA	FIDENZA	SUD EST	V. TARO-CENO	Totale
0-3	31	2	4		37
4-6	88	25	18	7	138
7-11	74	32	20	11	137
12-15	20	20	9	2	51
16-18	13	14		4	31
Totale 0-18	**226**	**93**	51	**24**	**394**
19-25	37	3		1	
26-30	4				
>30	3				
Totale	270	96	51	25	442

Programma adolescenza e giovane età adulta

Nel 2018 in tutti i Distretti è stata attivata l'Equipe Funzionale Adolescenza con la partecipazione dei professionisti delle diverse Aree disciplinari del DAI-SMDP, del Dipartimento Cure Primarie e i necessari raccordi con i Servizi Sociali, Educativi e Scolastici al fine di prendersi cura in modo integrato dell'adolescente, della sua famiglia e contesto di riferimento.

I dati della tabella 36evidenziano in questo segmento di età una lieve flessione dei pazienti in carico ai servizi .della neuropsichiatria infantile ed ad una sostanziale stabilità dei carichi di lavoro dei servizi per adulti

Tabella 36 - Utenza in carico DAISM DP nel segmento Adolescenza e Giovane Età

	SMA				NPIA				DP				Totale			
	2017	**2018**	**2019**	**2020**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
14-17 anni	11	39	22	6	724	804	765	595	16	14	10	11	751	857	797	612
18-25 anni	473	518	468	449	285	310	278	269	149	148	144	114	907	976	890	832
Totale	**484**	**557**	**490**	**455**	**1009**	**1114**	**1043**	**864**	**165**	**162**	**154**	**125**	**1658**	**1833**	**1687**	**1444**

Programma Salute Mentale nei Percorsi Giudiziari

Con il DPCM 1/4/2008 l'assistenza sanitaria negli Istituti Penitenziari è stata affidata al Servizio Sanitario Nazionale. Con le leggi 9/2012 e 81/2014 sono stati chiusi gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari e le misure di sicurezza di tipo detentivo sono diventate residuali. Questi cambiamenti legislativi hanno avuto importanti conseguenze organizzative, tecnico-scientifiche, culturali al fine di rendere effettivo il diritto alla salute a prescindere dallo stato giuridico. Per curare adeguatamente le persone private della libertà in Istituto di Pena o con altre misure giudiziarie nel territorio nel 2017 è stata istituita la UOC "Residenze Psichiatriche e Psicopatologia Forense".

Residenza Esecuzione Misure di Sicurezza (REMS)

Le attività della REMS temporanea di Casale di Mezzani, di riferimento per l'Area Vasta Emilia Nord, hanno evidenziato la necessità di pervenire a modelli operativi innovativi condivisi con Magistratura, amministrazione penitenziaria e servizi territoriali di riferimento, in una logica di inclusione sociale che tenda a contrastare lo stigma e la segregazione delle diversità, affrontando con misure di comunità i diversi problemi e le eventuali criticità.

Tabella n. 37: Residenza Esecuzione Misure di Sicurezza. Anni 2017-2020

	2017	2018	2019	2020
Posti	10	10	10	10
Utenti	19 (3416 gg di degenza)	15 (3582 gg di degenza)	16 (2989 gg di degenza)	13 (3576 gg di degenza)
di cui extraprovincia	13 (2388 gg di degenza)	9 (1816 gg di degenza)	10 (1897 gg di degenza)	7 (1708 gg di degenza)
di Cui extraRER (o stranieri o senza dimora)	1 (30 gg di degenza)	4 (1036 gg di degenza)	0	0
Utenti dimessi	10 (di cui 1 ExtraRER, 7 extraprovicnia)	5 (tutti extra provincia)	7 (di cui 5 extraprovincia)	3

Nel corso del 2020 in Rems sono state accolte 4 persone e dimesse 2; gli ingressi provenivano rispettivamente da ATSM RE, da OPAML di Parma, dall'II.PP di Parma e da Comunità Terapeutica di BO, e sono afferenti ai territori di RE, PR, BO e FE. Le persone dimesse hanno avuto progetti alternativi sui territori di riferimento quali PR e RE.

Al 31 dicembre 2020 in REMS vi sono 10 ospiti con misura di sicurezza definitiva e così suddivisi per Dipartimenti di Salute Mentale: 4 PR, 2 BO, 1 RN, 1 FE, 1 RE, 1 MO.

Per 9 ospiti REMS è presente la presa in carico territoriale ed è stato formulato il PTRI (Progetto Terapeutico Riabilitativo Individualizzato) entro 45 giorni, aggiornati a cadenza trimestrale così come previsto dal protocollo tra Magistratura, Regione Emilia Romagna ed UEPE.

Alla fine 2020 risultano in lista d'attesa per l'ingresso in REMS 5 persone dell'Area AVEN, di cui 3 sono attualmente in ATSM a RE, 1 a domicilio ed 1 in II.PP di Parma.

Pazienti con misure giudiziarie non detentive

Nella tabella 38 vengono elencatii pazienti in carico al DAISM-DP di Parma con percorsi giudiziari sul territorio della provincia di Parma.

I pazienti sono in larghissima parte maschi (42 su 48) con diagnosi di Psicosi (51.2%) o di Disturbo della personalità (35,6%). Quasi il 20% sono stranieri

Tabella n. 38: Pazienti con misure giudiziarie non detentive. Anni 2019-2020

	2019	**2020**
Progetti Residenziali	26	25
Di cui		
OPA VML	3	2
Rete DAI-SMDP	20	20
Strutture Extraprovinciali	2	3
Domicili	16	14
Tipologia P. Giudiziario:		
Arresti domiciliari	10	11
Libertà Vigilata	23	24
Affidamento in Prova	3	3
Libero	6	12
Pazienti seguiti dal Territorio		
CSM Parma Est	18	15
CSM Parma Nord Ovest	19	14
CSM Fidenza	9	7
CSM Sud Est	4	3
CAGE	1	0
Csm Valli Taro e Ceno	0	1
Utenti REMS	5	4

Salute Mentale Dipendenze Patologiche negli Istituti Penitenziari

Gli Istituti Penitenziari di Parma sono caratterizzati da una particolare complessità; sono infatti composti da diverse realtà differenziate tra loro, non solo per il tipo di regime di sorveglianza applicato alle diverse tipologie di detenuti, ma anche per la complessità e le comorbilità dei pazienti.

Gli interventi dell'équipe sono orientati su 4 ambiti principali: lo screening sui Nuovi Giunti e la gestione del disagio psicologico; la diagnosi e cura dei pazienti con patologie psichiatriche; il trattamento dei pazienti con dipendenze (sostanze, alcool, dipendenze comportamentali); la partecipazione al protocollo locale sulla prevenzione del rischio autolesivo e suicidario.

Il Nucleo Assistenza e Riabilitazione dei detenuti dipendenti (NARD) è un'équipe multidisciplinare che opera all'interno degli Istituti di Pena di Parma e svolge attività di osservazione e diagnosi, presa in carico (a seguito di certificazione) del paziente con problematiche di dipendenza e, in accordo con i SerDP di residenza dell'utente, individua il percorso terapeutico che può essere svolto all'interno del carcere e sul territorio.

Nell'analisi dei dati si è mantenuta la distinzione adottata nei precedenti report di trattare i dati di questo Servizio a parte, scorporandoli da quelli dei soggetti che si trovano in condizione di libertà. Se un utente è stato in carico al NARD e a un SerDP territoriale nel periodo di riferimento è conteggiato sia in questo che nei successivi paragrafi.

Tabella 39 -Utenti in carico al NARD per tipologia - Anni 2015-2020

Tipologia	Stato utente	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Δ 2020-2019
Droghe	Nuovi	68	54	65	61	76	56	-20
	Già conosciuti	125	131	118	131	130	121	-9
	Totale in carico	**193**	**185**	**183**	**192**	**206**	**177**	**-29**
Alcol	Nuovi	7	12	12	5	14	4	-10
	Già conosciuti	16	11	14	17	10	14	4
	Totale in carico	**23**	**23**	**26**	**22**	**24**	**18**	**-6%**

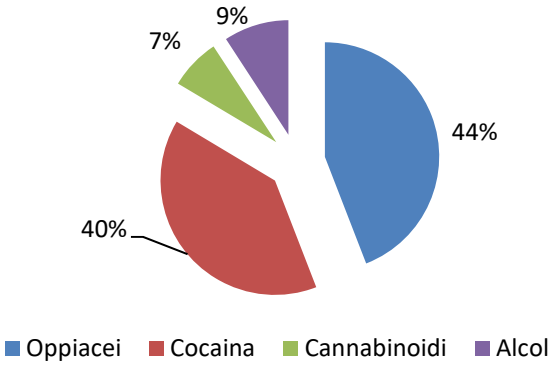
Risulta sostanzialmente stabile, con un lieve *trend* di aumento, la quota dei pazienti con cittadinanza straniera in carico al Servizio NARD, che è comunque molto superiore a quella dei servizi territoriali: nel 2020 rappresentano il 44,1%degli utenti seguiti (tabella 40).

Tabella 40 -Utenti stranieri in carico al NARD - Anni 2013-2020

Anno	Tipologia utente		Totale	%
	Alcol	Droghe		
2013	9	78	**87**	39,5
2014	13	84	**97**	42,7
2015	13	73	**86**	39,8
2016	16	78	**94**	45,2
2017	19	78	**97**	46,4
2018	14	73	**87**	40,7
2019	14	89	**103**	45,2
2020	11	75	**86**	44,1

Analizzando i dati riguardanti la sostanza d'abuso primaria emerge che la cocaina riguarda il 35% (contro il 40%) degli utenti in carico, mentre gli oppiacei risultano la sostanza primaria per 43% (il 38% nel 2017) dei pazienti. Permane, come dato di criticità, la difficoltà ad individuare percorsi terapeutici specifici per pazienti con dipendenza comportamentale (*gambling*) che appaiono un fenomeno in crescita sia come dipendenza primaria che come co-dipendenza con l'utilizzo di sostanze ed alcol.

Figura 4 - Utenti NARD per sostanza primaria - Anno 2020



Programma Dipendenze Patologiche

Nella seguente sezione sono riportati i dati dell'anno 2020 relativiall'utenza in caricoai Servizi per le Dipendenze Patologiche(SerDP) provenienti dal Sistema Informativo SistER, in uso in tutta la regione Emilia Romagna.
Pur con le norme in atto per la gestione della pandemia, l'area ha sempre assicurato la pronta accoglienza e la continuità di cura.

I Servizi per le dipendenze patologiche (SerDP)

I dati dell'utenza che si rivolge ai SerDP rappresentano un importante indicatore epidemiologico, definito dall'Osservatorio Europeo delle Droghe e delle Tossicodipendenze (OEDT) come "domanda di trattamento". I dati esposti sono riconducibili alle aree problematiche "Droghe e/o farmaci", "Alcol" e "Gioco d'azzardo patologico". Dal 2015 sono inseriti nel Sistema Informativo SistER anche i dati relativi all'attività del Centro Antifumo (CAF) che sono esposti in un paragrafo dedicato. È opportuno precisare che ai SerDP accedono anche persone con bisogni differenti dalla cura: richieste di attestazione d'assenza d'uso di sostanze (a scopo di adozioni e porto d'armi), certificazioni di non tossico/alcol dipendenza per categorie di lavoratori con mansioni a rischio e a favore di utenti inviati dalla Commissione Medica Locale (in seguito a violazioni degli art. 186 e/o 187 CdS).

Tabella 41 - Utenti in carico nuovi/già conosciuti per area problematica (2017-2020).

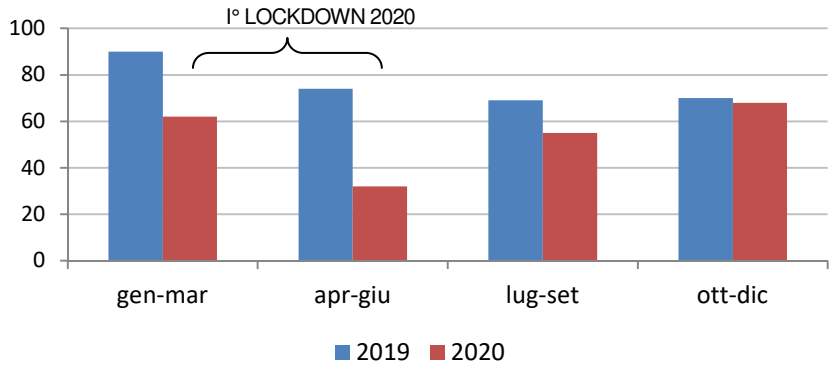
Area problematica	2017	2018	2019	2020	Δ%2020-2019
DROGHE E/O FARMACI					
Nuovi	189	164	170	125	-26,5
Già conosciuti	1114	1132	1115	1152	3,3
Totale area	**1303**	**1296**	**1285**	**1277**	**-0,6**
ALCOL					
Nuovi	108	130	99	82	-17,2
Già conosciuti	407	408	398	413	3,8
Totale area	**515**	**538**	**497**	**495**	**0,4**
GIOCO					
Nuovi	39	33	34	10	-70,6
Già conosciuti	68	69	71	79	11,3
Totale area	**107**	**102**	**105**	**89**	**-15,2**
Totale	**1925**	**1936**	**1887**	**1861**	**-1,4**

Nonostante la pandemia, dall'analisi dei dati (tabella 41) si rileva complessivamente una sostanziale stabilità della domanda di trattamento (-0,7%), con un'utenza tossicodipendente in carico pari a 1277 pazienti nel 2020 (-0,6% rispetto al 2019), con una diminuzione dei nuovi casi (-26%). Similmente si osserva una stabilità nell'area "Alcol" (+0,4%), anche a fronte di un calo delle nuove richieste di trattamento (-17%). Un calo più evidente si registra

nell'area "Gioco" (-15,2%), dato anch'esso condizionato dalla diminuzione dei nuovi programmi che sono circa 1/3 rispetto a un trend piuttosto stabile negli ultimi anni

Dall'analisi dei dati dei nuovi utenti (figura 3) si rileva un calo delle nuove richieste di trattamento in tutte le aree, particolarmente accentuato nei primi due quadrimestri e con un incremento nella seconda parte dell'anno.

Figura 5 - Nuovi utenti: confronto 2019-2020 (v.a.)



Da un confronto storico dei dati si possono osservare ancor meglio i *trend* per quanto riguarda il totale degli utenti in carico (figura 6) e le nuove richieste di trattamento (figura 7).

Figura 6 - Totale utenti in carico per area problematica - 2006-2020

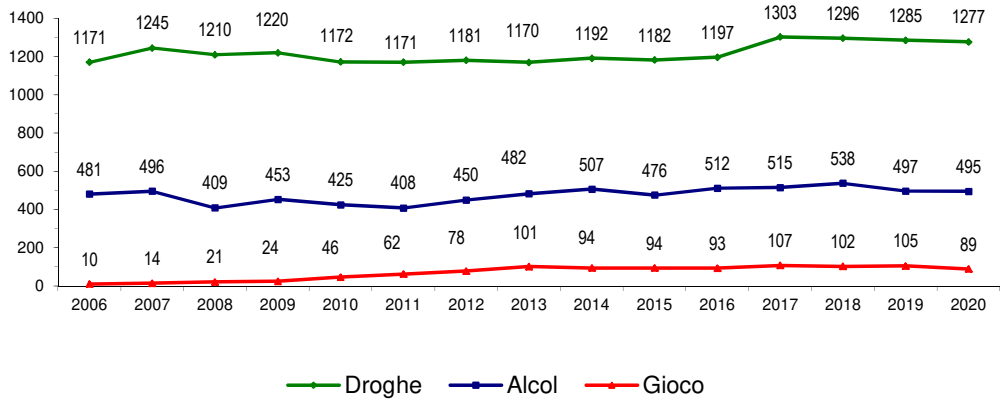
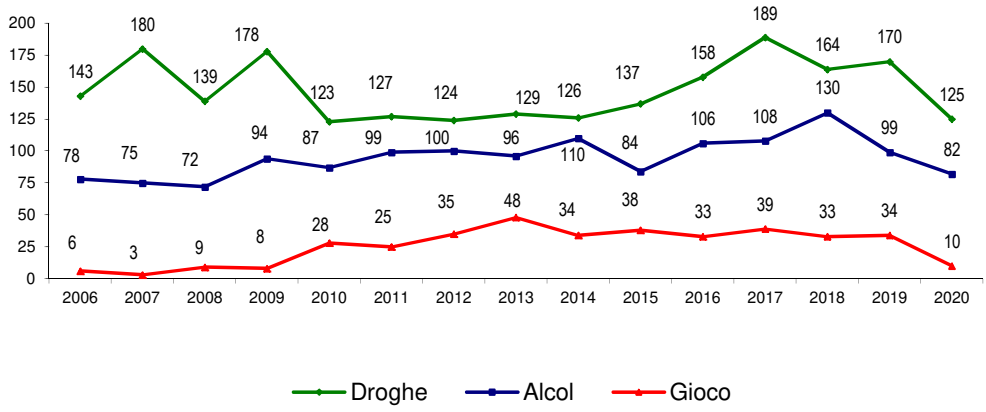


Figura 7 - Nuovi utenti in carico per area problematica: 2006-2020



Non si rilevano sostanziali differenze rispetto agli anni precedenti nella distribuzione percentuale delle tipologie di utenti dei Servizi per le Dipendenze: l'area "Droghe e/o farmaci"è responsabile del 66,9% dei programmi terapeutici dei SerDP, mentre l'"Alcol" del 27,8% e il "GAP" del restante 5,3%.

Non si rilevano sostanziali differenze rispetto agli anni precedenti nella distribuzione percentuale delle tipologie di utenti dei Servizi per le Dipendenze: l'area "Droghe e/o farmaci"è responsabile del 69% dei programmi terapeutici dei SerDP, mentre l'"Alcol" del 27 % e il "GAP" del restante 5%.

Dalla distribuzione per Distretto Socio-sanitario dell'utenza in trattamento, si riscontra che il Distretto di Parma resta, in modo stabile, il territorio che raccoglie la maggior parte dell'utenza in carico, pari al 60%di tutti i pazienti delle DP, seguita dal Distretto di Fidenza (19%), del Sud Est (13%) e infine dal Distretto Valli Taro e Ceno (9%).

Tabella 42 - Utenti in carico per Distretto socio sanitario- Anno 2020

Distretto socio sanitario	Alcol	*di cui* nuovi	Droghe	*di cui nuovi*	Gioco	*di cui nuovi*	Totale	*di cui* nuovi
Parma	283	48	773	79	59	5	1115	132
Fidenza	89	14	243	22	16	3	348	39
Sud Est	73	15	162	21	4	2	239	38
Valli Taro e Ceno	50	5	99	3	10	0	156	8
AUSL	**495**	**82**	**1277**	**126**	**89**	**10**	**1861**	**217**

Al fine di rendere maggiormente confrontabili i dati distrettuali sono stati calcolati i tassi di prevalenza, per l'anno 2020, nelle aree "Alcol" e "Droghe e/o farmaci" utilizzando la seguente formula:

$$\frac{\text{N utenti residenti in carico tra i 15 e i 64 anni}}{\text{Popolazione residente al 01.01.2021 tra i 15 e 64 anni}} \times 10.000$$

Il Distretto di Parma conferma il tasso di prevalenza più alto nell'area Droghe e Farmaci, che passa da 43,6 a 48,0 ogni 10.000 abitanti. Rispetto all'anno precedente, si osserva un decremento nei Distretti di Fidenza (da 39,7 a 34,2), nel Sud Est (da 36,9 a 30,7) e nelle Valli Taro e Ceno (da 39,5 a 37,5). Nell'area Alcol il tasso più alto si rileva nel distretto di Parma (16,9).

Tabella 43- Prevalenza (x10.000 abitanti) utenti Alcol e Droghe. Anni 2018-20

Distretto socio sanitario	2020			Prevalenza Alcol (x 10.000 ab.)			Prevalenza Droghe (x 10.000 ab.)		
	Popolazione *target*	Alcol	Droghe	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Parma	148.185	250	711	17,6	15,7	16,9	47,4	43,6	48,0
Fidenza	66.085	83	226	16,0	14,7	12,6	37,9	39,7	34,2
Sud Est	49.110	67	151	15,3	13,2	13,6	38,9	36,9	30,7
Valli Taro e Ceno	26.147	40	98	16,6	18,6	15,3	30,3	39,5	37,5
AUSL	289.527	**440**	**1186**	**16,8**	**15,3**	**15,2**	**42,2**	**41,2**	**41,0**

Per quanto attiene all'età, la domanda di cura ai servizi coinvolge un ampio *range*, che nel 2020 è compreso tra i 16 e 81 anni. Si mantiene la caratteristica di un'età più elevata per gli utenti in trattamento per problematiche alcol-correlate e per i giocatori d'azzardo, rispetto all'utenza con problematiche droga-correlate (età media: Alcol=50; Gioco=48; Droghe=41). La classe d'età entro cui è compreso il maggior numero di utenti, considerando tutte e tre le aree problematiche, resta anche per il 2020 quella tra 41-50 anni (29%). Si conferma il *trend* di invecchiamento della popolazione della'area "Droghe e/o Farmaci",in cui la percentuale di assistiti con età superiore ai 40 anni è pari al 52% (era 49% nel 2019). Gli utenti minorenni rimangono una quota molto ridotta delle prese in carico nel settore delle Dipendenze (0,6%) e, in modo coerente con gli anni precedenti, appartengono quasi esclusivamente all'area "Droghe e/o farmaci".

Tabella 44 - Classi d'età per area problematica - Anni 2019-2020

Classi età	ALCOL		DROGHE		GIOCO		TOTALE	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
<18	0	1	10	10	0	0	10	11
18-30	22	20	271	239	9	10	302	269
31-40	78	75	375	359	15	14	468	448
41-50	153	142	376	378	24	18	553	538
51-60	157	173	219	253	36	35	412	461
>60	87	84	34	38	21	12	142	134
Totale	**497**	**495**	**1277**	**1284**	**105**	**89**	**1887**	**1861**

Per quanto riguarda la distribuzione di genere, si riscontra un maggior numero di utenti di sesso maschile, (80%) con differenze, anche sostanziali tra le aree. Nell'area "Droghe" le femmine risultano il 17%, con un rapporto di 1 donna ogni 4,8 uomini, nell'area Gioco si riscontra ulteriore diminuzione dell'utenza di sesso femminile (dal 16% nel 2019 all'11% nel 2020), mentre nell'area "Alcol" si osserva un valore percentuale nettamente più alto pari al 29%,che corrisponde a un rapporto M:F pari a 2,4.

Figura 8- Distribuzione di genere per area problematica (%) - Anno 2020

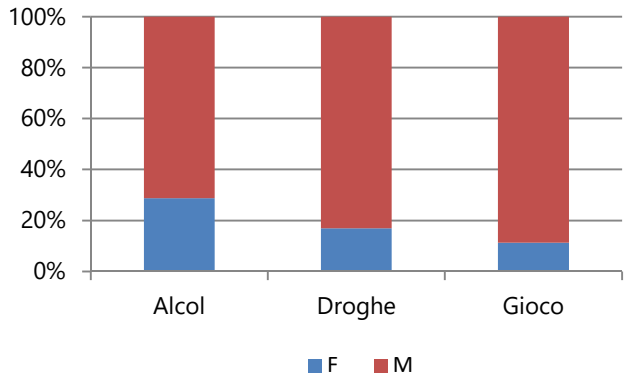
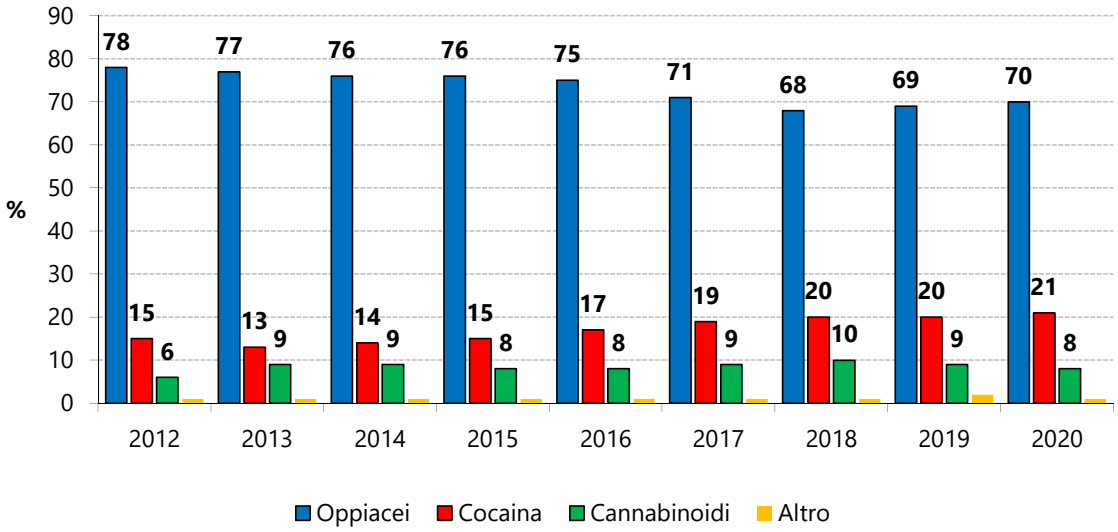


Tabella 45- Utenti per area problematica e tipo di cittadinanza - Anno 2020

Area problematica	Cittadinanza		Totale	Stranieri (%)
	Italiana	Straniera		
Alcol	408	87	495	17,6
Droghe e/o farmaci	1136	141	1284	11,0
Gioco	81	8	89	9,0
Totale	1625	236	1861	12,7

Complessivamente, con differenze consistenti nella rappresentatività nelle aree problematiche, nel 2020, rimangono sostanzialmente stabili o in lieve aumento gli utenti in carico di cittadinanza straniera che si attestano sul 13% del totale (erano 12% del 2019). Il dato risulta leggermente più basso, ma sostanzialmente in linea,alla percentuale di stranieri presente sul territorio che è tra le più alte a livello nazionale. All'interno della tipologia "Droghe e/o farmaci" si osserva una sostanziale stabilità dei soggetti di cittadinanza straniera, che nel 2020 equivale all'11%. Tra gli alcolisti il numero di stranieri è storicamente più alto e nel 2020 ha subito un lieve incremento passando dal 15,7% del 2019 al 17,6% del 2020.

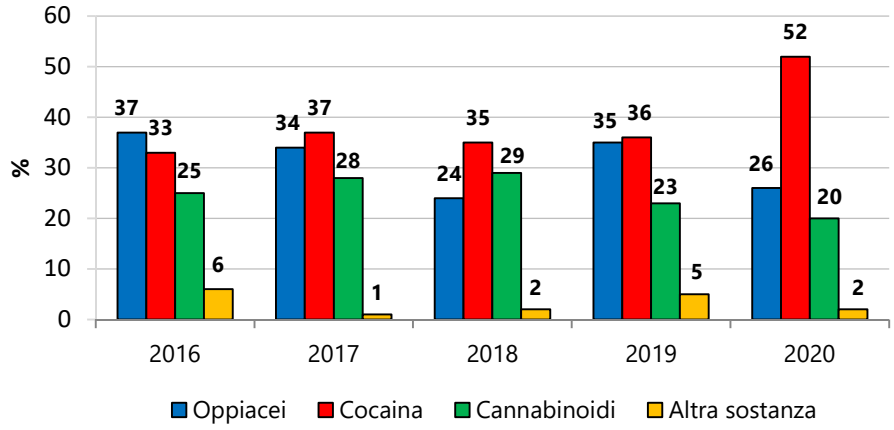
Figura 9- Utenti per dipendenza primaria (area Droghe e/o farmaci) – Anni 2012-2020 (%)



All'interno dell'area problematica "Droghe e/o farmaci" si confermano gli oppiacei quale sostanza principale (70%), mentre la cocaina si assesta nel 2020 sul 21%. Stabile la quota di utenti con sostanza primaria cannabinoidi che nell'ultimo anno ha raggiunto 8%.

Un indicatore più sensibile ai mutamenti dei pattern di consumo è rappresentato dalla tipologia di sostanze utilizzate dai nuovi soggetti che entrano in trattamento ogni anno (figura 10). Si consolida il *trend* di aumento dei nuovi utenti con sostanza primaria cocaina, che anche nel 2020 continua ad essere superiore alla percentuale dei nuovi utenti con sostanza primaria oppiacei. Nel 2020, infatti, il 52% dei nuovi utenti è stato preso in carico per problematiche di dipendenza primaria da cocaina, mentre il 26% (contro il 35% del 2019) si è rivolto al servizio con una domanda di trattamento per abuso/dipendenza da oppiacei e il 20 % per cannabinoidi (contro il 23% del 2019).Questo cambiamento che appare ormai sempre più stabile ed evidente pone numerose sfide cliniche e organizzative ai Servizi per le Dipendenze.

Figura 10 – Nuovi utenti per sostanza primaria Anni 2016-2020 (%)



La residenzialità nelle Dipendenze Patologiche

Le strutture accreditate gestite dagli Enti del privato sociale (tradizionalmente conosciute come Comunità Terapeutiche) e dalle ONLUS costituiscono un'importante risorsa terapeutica per il trattamento dei soggetti dipendenti da sostanze d'abuso (negli ultimi anni anche per il trattamento di dipendenze comportamentali come il GAP). Nella tabella 47 sono riportati il numero di pazienti inseriti dai SerDP di Parma e le relative giornate di degenza.

Tabella 47 - Inserimenti residenziali Anno 2020

Residenzialità DP		n° inserimenti	giornate
Strutture sanitarie accreditate per le dipendenze patologiche	Amici per la Liberazione dalle Droghe	62	11.113
	Comunità Betania	35	5.066
	Centro di Solidarietà l'Orizzonte*	35	4.708
Strutture convenzionate	San Cristoforo Onlus	13	3.710
Fuori Provincia		19	2.865
TOTALE		164	27.462

* Ora Fondazione CeISOnlus

Sono stati 151 i pazienti che nel 2020 hanno usufruito di trattamento residenziale (erano 147 nel 2019 e 166 nel 2018) che hanno attivato 164 inserimenti. Gli utenti avevano un età media pari a 40,6 anni e, di questi, 130 (86%) erano di sesso maschile, mentre 18 (12%) erano soggetti a provvedimenti giudiziari. L'area problematica che maggiormente ricorre a questa risorsa è quella "Droghe e farmaci" che conta 116 individui inseriti (77% degli invii), seguita dall'area "Alcol" (20%) e "Gioco" (3%).

Unità di strada

L'Unità di Strada (UdS) ha come mandato la riduzione delle conseguenze negative dei comportamenti messi in atto dai consumatori di sostanze psicoattive, per i consumatori stessi e per la società (ricadute sulla salute pubblica), oltre a mantenere una capacità di osservazione sensibile sull'evoluzione del fenomeno per i servizi che operano indoor. Le sue attività si inseriscono nelle " funzioni di prossimità anche come porta di accesso al sistema dei servizi" (DGR 1533/2006 Regione Emilia Romagna). Nel 2020 nonostante la pandemia da Covid-19 non sono stati interrotti i servizi offerti, le nuove condizioni sociali e sanitarie hanno visto l'UdS impegnata in una rapida riprogettazione di attività e progetti nei diversi setting di intervento: strada, scuole, carcere, notti, centri giovani, drop-in, social.

Interventi di Riduzione del Danno(RDD)

Il 2020, a causa della pandemia da Covid-19, ha visto importanti cambiamenti sia nelle modalità di accesso ai servizi sia nelle geografie delle aggregazioni spontanee sul territorio, oggetto di intervento. Gli **interventi di**

Outreach in strada non sono mai stati sospesi (salvo per il primo mese di lockdown, in attesa del reperimento degli adeguati dispositivi di protezione), in quanto si è valutato che la presenza di personale sanitario sulle strade della città fosse importante per raggiungere sia gruppi di consumatori che soggetti che vivono la dipendenza associata a condizioni di marginalità, i quali di fatto, nonostante i divieti, hanno trovato modi e luoghi per ritrovarsi. La nuova condizione ha favorito un lavoro di comunità rendendo necessaria la condivisione di modalità e strumenti adeguati. E' stata attivata una rete stabile tra tutte le realtà che svolgono attività di strada su Parma e provincia: il ruolo di coordinamento dell'equipe sanitaria dell'UdSAusl ha reso più facile adottare i cambiamenti necessari al riprendere il lavoro in sicurezza. Con le Associazioni di volontariato che operano in strada in ambito marginalità e con gli operatori di Cooperative Sociali che svolgono interventi di educativa di strada per il Comune, gli incontri periodici hanno incluso anche le realtà provinciali portando a modalità condivise in tutto il territorio. Nel capoluogo sono state effettuate 67 uscite di Strada pomeridiane/serali che hanno prodotto 966 contatti (dove per contatto si intende un'interazione significativa che può prevedere l'erogazione di materiale di prevenzione e/o l'avvio di un rapporto con l'operatore sul tema dei consumi di sostanze/dei comportamenti a rischio). La media dei contatti ad uscita nel 2020 è lievemente aumentata (14,5 nel 2020 contro 13,1 nel 2019). Abbiamo ipotizzato che proprio la pandemia abbia favorito l'aggancio del "sommerso". L'essere presenti in un momento delicato come quello del lockdown ha reso l'UdS l'unico ponte presente e non "virtuale" con i servizi e con i presidi di prima necessità. L'attività di prossimità svolta in Strada è stata prevalentemente quella di dare informazione sulle nuove regole di accesso ai servizi e orientare chi si incontrava quando, nonostante la situazione di emergenza, non aveva altra possibilità che la strada. L'UdS ha contattato 219 nuovi consumatori (22,7% dei contatti complessivi, contro il 26.7% dell'anno precedente).

Nella **struttura di bassa soglia di accesso Drop-in** nel 2020, a causa della pandemia e delle limitazioni imposte per garantire protezione e prevenzione, lo scenario è nettamente cambiato. Il numero di soggetti che si è rivolto alla struttura è sostanzialmente stabile, mentre sono cambiati in modo radicale la modalità di accesso, la frequenza, lo svolgimento di attività presso la struttura, la possibilità di sviluppare relazioni approfondite con soggetti nuovi.

Tabella 48- Utenti Drop-In. Anni 2019-2020

	2019	2020
N° utenti	233	224
Nuovi	12%	26%
F	21%	18%
Giovani: 18-30 anni	13%	16%
Fascia di età più numerosa: 41-50 anni	41%	37%
Vive in strada	25%	29%
Stranieri	26%	33%
Senza permesso soggiorno	23%	33%

Sono stati seguiti 224 soggetti (71% consumatori di Droghe e/o farmaci, 23,7% consumatori di Alcol, 5,4% familiari), si osserva un'aumentata presenza di categorie più vulnerabili: giovani/giovanissimi, senza dimora e

stranieri senza permesso di soggiorno; i consumatori di Droghe e/o farmaci che si dichiarano poliassuntori sono il 42%. L'emergenza sanitaria ha fatto emergere quelle situazioni che non accedevano ai servizi di cura o di prima accoglienza. In Drop-in, come in strada, è venuta meno la possibilità di stare e sostare nei luoghi e vicino alle persone, le precauzioni necessarie hanno reso più difficile in alcuni casi la costruzione lenta di una relazione di cura, obiettivo che l'operatore di strada raggiunge poco alla volta, rispettando i tempi di chi incontra. D'altro canto i cambiamenti avvenuti improvvisamente hanno portato molte persone nuove a rivolgersi al servizio per chiedere aiuto: persone invisibili ai servizi per la prima volta hanno cominciato a recarsi in Drop-in, attendere gli operatori in strada, accedere al dormitorio, recarsi in mensa, nell'arco della stessa giornata. Questo ha permesso un monitoraggio costante della loro salute da parte dei professionisti dell'Ausl. Per le persone senza fissa dimora, impossibilitate a rispettare l'obbligo di stare a casa, l'UdS ha predisposto delle autocertificazioni come da indicazione degli Avvocati di Strada. A supporto di soggetti fragili seguiti dall'UdS, che a causa della pandemia hanno vissuto un periodo di maggiore isolamento, allo scopo anche di monitorarne i consumi e i rischi, sono proseguiti gli interventi a domicilio (n.26) ed è stata implementata un'attività online attraverso chiamate telefoniche e il servizio di messaggistica del profilo Facebook dell'UdS (n.122).

Il **Dormitorio di bassa soglia "La sosta",** gestito in collaborazione con la Comunità Betania (convenzione AUSL-Comune di Parma-CT Betania), svolge un'attività di accoglienza notturna per persone non *drug-free* di entrambi i sessi, svolgendo sia una funzione sanitaria di riduzione del danno (tutela rispetto alle malattie e al rischio di morte), sia educativa, facilitando lo sviluppo di percorsi individualizzati sul modello della *stepped care*, modulando gli interventi a seconda delle condizioni e della motivazione dei pazienti. Laddove possibile vengono avviati percorsi socio-sanitari che rappresentino una valida alternativa alla situazione di estrema precarietà in cui le persone si trovano. Negli anni il Dormitorio ha garantito l'accoglienza delle persone più compromesse (uomini e donne attivi con le sostanze), ha consentito di ridurre drasticamente il numero di persone che rimangono a dormire in strada sul nostro territorio, ha consentito di valutare e gestire situazioni di criticità dei soggetti supportando al contempo i servizi sanitari territoriali che ne hanno richiesto l'ospitalità temporanea. L'accoglienza diurna c/o il Drop-in, grazie alla permanenza dei soggetti al dormitorio, rappresenta il punto di snodo attraverso il quale vengono attivati e coinvolti i servizi territoriali sociali e sanitari per i diversi percorsi dei pazienti. Durante il periodo pandemico il Dormitorio ha avuto anche una funzione di supporto ai SerDP nei casi in cui si è reso necessario un periodi di attesa per l'espletamento del tampone e lo scorrimento delle liste di attesa per l'accesso al ricovero dei pazienti nelle cliniche. All'interno di accordi con l'Igiene Pubblica (percorso per la costruzione di un protocollo per la prevenzione e gestione casi Covid nella bassa soglia) sono stati garantiti tamponi periodici ai soggetti che accedono al Dormitorio. Sono proseguiti gli incontri di gruppo con gli ospiti, una modalità scelta per ribadire le regole di convivenza, abbassare e prevenire la conflittualità tra gli ospiti, consentire la socializzazione dei percorsi di ciascuno, favorendo processi solidali e lo sviluppo di *problem-solving* attraverso l'attivazione in gruppo (*peer to peer*).

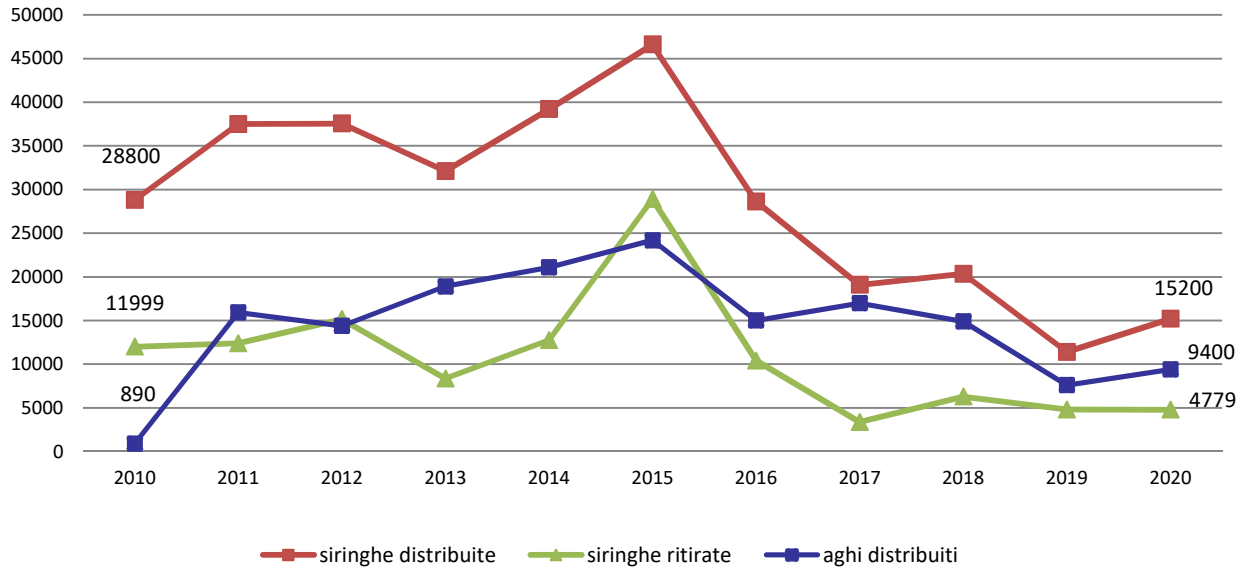
Nel 2020 "La Sosta" ha ospitato 51 soggetti: 6% femmine, 49% residenti a Parma e provincia, 45% stranieri.

Tab. 49 Dati 2019-2020. Tipologie di esito a seguito del periodo di permanenza al dormitorio

	2019	2020
Avvio progetto di cura con SerDP	16	18
Funzione salvavita RDD	17	17
Miglioramento condizioni di vita / autonomie	8	7
di cui percorsi regolarizzazione/rinnovodocumenti	6	
Rientro al paese/città d'origine	3	1
Ricovero per disintossicazione	2	3
Carcerazione	2	4
Decessi	1	1

L'uso iniettivo dei consumatori attivi è uno dei comportamenti a rischio più monitorati. Dal 2016 si è osservata una diminuzione progressiva della richiesta di siringhe sterili e il ritiro di siringhe usate ha seguito un andamento parallelo. Variazioni riferibili ai mutamenti dei pattern di consumo, al viraggio su altre sostanze, ai cambiamenti di mercato. Nel 2020 si osserva un lieve aumento nella distribuzione del materiale sterile.

Figura 11- Materiale sterile distribuito e materiale ritirato (2010-2020)



In ambito Riduzione del Danno, il 2020 ha visto la partecipazione di Parma ad un progetto innovativo regionale denominato **Self checkingFentanyl**. Il progetto consiste nella distribuzione di test rapidi per la rilevazione di Fentanyl in campioni di sostanze e urine a consumatori di eroina conosciuti dall'UdS e ad utenti dei servizi di cura SerDP del territorio. Il Fentanyl è un oppioide sintetico circa 100 volte più potente della morfina, il cui utilizzo in minime quantità, anche come sostanza da taglio, può provocare overdose. Il progetto nasce per giungere tempestivamente e precocemente a monitorare un fenomeno che ha dato luogo ad una vera e propria allerta sociale in altri Paesi. L'Obiettivo è stato quello di offrire ai consumatori uno strumento finalizzato alla riduzione del danno per prevenire morti per overdose di Fentanyl, monitorare la presenza di Fentanyl nelle sostanze da taglio usate sul territorio, sensibilizzare i consumatori rispetto alla protezione della propria salute avviando pratiche di

auto-tutela. E' stata realizzata una formazione congiunta tra UdS-referenti dei SerDP di Parma e provincia-utenti afferenti al Drop-in, su Fentanyl, kit di analisi e auto-somministrazione, autotutela e promozione dell'uso del test tra *peer*. L'UdS ha distribuito 27 test a consumatori attivi, somministrato un questionario di conoscenza (sulla sostanza, modalità di reperimento, effetti percepiti ed eventuali effetti non desiderati), rilevato 2 test positivi al Fentanyl. All'interno del progetto regionale è stato messo a punto un protocollo da attivare in caso di risultato positivo del test. Il progetto è stato sospeso nel 2020 dopo 3 mesi di attività, a causa della pandemia Covid-19 che ha costretto a rivedere i progetti e le modalità di lavoro. Ciò nonostante, gli esiti positivi in termini di coinvolgimento attivo dei consumatori e di riscontro in termini conoscitivi sul mercato delle sostanze daranno luogo ad una ripresa del progetto per l'anno successivo.

Interventi di Riduzione dei Rischi (RDR) sulla popolazione giovanile

Una parte di attività dell'Uds rivolta a giovani e giovanissimi ha dovuto riconvertirsi per continuare a raggiungere l'utenza nonostante la distanza, continuando a rispondere ai bisogni quotidiani e a quelli nuovi, frutto della pandemia. In collaborazione con la Cooperativa Eidè nasce il**Progetto Digitale** che in modo specifico (analisi dei target) e trasversale (applicazione nei diversi ambiti di intervento Outreach, Drop-in, Loisir, Scuole) definisce le azioni e i "prodotti" per raggiungere e tenere agganciata l'utenza diurna e notturna. Si sono inoltre mantenuti i contatti con organizzatori di eventi del mondo della notte coi quali sono state sviluppate intense collaborazioni negli anni precedenti. Sono stati realizzati prodotti di prevenzione dei rischi e riduzione del danno (meme, rubriche, interviste, disegni, cartoline informative, video in stop motion) pubblicati su Instagram, profilo e pagina Facebook, pagina Facebook,TikTok, canale Youtube dell'UdS. Utilizzando i social si è riusciti a restare in rete con le altre Unità di Strada condividendo attività e contenuti.

Gli interventi di prevenzione del **Progetto Notti** si sono svolti nei primi 2 mesi dell'anno e durante la stagione estiva, nella quale i nuovi DPCM hanno permesso ai locali di riaprire, seppur con ingressi contingentati e normative igienico-sanitarie molto rigide. Alcune discoteche di Parma si trasformano in questa fase in disco-pub, per poi tornare a chiudere nel secondo lockdown. Nel 2020 sono state effettuate 19 uscite serali-notturne su Parma e provincia: n.4 sono state effettuate in locali ed eventi prima del lockdown dovuto alla pandemia di Covid-19 (dove sono stati effettuati interventi di prevenzione anche tramite l'etilometro), n.5 sono state effettuate in locali notturni che hanno riaperto a seguito di riorganizzazione delle modalità di fruizione, n.10 uscite sono state effettuate in fascia oraria serale in centro città dove si sono radunati gruppi giovanili nel periodo delle restrizioni di legge.

Tabella 50 - Progetto Notti Anno 2020

Totale soggetti contattati progetto Notti (con e senza etilometro)		868
Soggetti testati con etilometro		223
Neo-patentati (conseguimento patente nei primi 3 anni e conducenti <21anni)	47%	
Vive a Parma e provincia	89%	
18-24 anni	72%	
Maschi	77%	
Alcolemia sopra limite legale	62%	
Soggetti a rischio (sopra il limite di legge e con intenzione di guidare)		52
Soggetti sensibilizzati*	64%	
Soggetti responsabili (entro il limite legale + oltre il limite senza intenzione di guida + sensibilizzati)	91%	
Materiali erogati: 858 profilattici, 353 etiltest monouso, materiale informativo su sostanze, alcol, servizi, malattie sessualmente trasmissibili		

* *soggetti che hanno manifestato l'intenzione di seguire uno degli stimoli degli operatori - soprattutto aspettare lo smaltimento dell'alcol o passare le chiavi per fare guidare un amico sobrio - dichiarando di non rimettersi alla guida in condizioni critiche per sé e per gli altri.*

Nei luoghi informali di aggregazione è proseguito anche nell'estate 2020 il progetto **Camper al Parco Ducale**, realizzato da UdS e Cooperativa Eidè in collaborazione con altri Enti (Comune, Polizia Municipale). A seguito delle restrizioni del DPCM relative al distanziamento interpersonale, è stato ripensato l'allestimento in chiave alternativa, sempre nel rispetto delle regole, e implementata l'offerta del servizio aggiungendo materiale e informazioni su aspetti sanitari e normative vigenti in tema di Covid.Gli accessi alla postazione Camper nel 2020 hanno registrato un lieve incremento e un impatto positivo sulla cittadinanza. Su 13 giorni di permanenza si sono registrati 295 contatti, con una media di 23 contatti ad uscita (contro una media di 18 nel 2019). Il target raggiunto di età compresa tra i 16-24 anni ha avuto un costante incremento negli anni in cui si è svolto il progetto (dal 44% nel 2018 si è passati al 59% nel 2020), contatto che nel 2020 è stato incentivato affidando la diffusione degli appuntamenti settimanali ai canali social dell'UdS (Facebook e Instagram) che hanno preannunciato regolarmente la presenza al Parco Ducale. Le informazioni richieste a chi si è rivolto a Camper sono state accompagnate spesso dalla consegna di materiali o presidi (333 profilattici, 82 etiltest monouso, 92 materiali informativi), attraverso i quali si offre una sensibilizzazione all'utilizzo e si affrontano tematiche di protezione individuale e collettiva.Nonostante l'impossibilità di utilizzare il camper come luogo protetto per effettuare colloqui di *counseling* (misure di prevenzione COVID), la richiesta di colloqui in forma riservata ha avuto un significativo incremento e sono stati effettuati 39 colloqui di consulenza (contro i 16 dell'anno precedente).

Ambulatorio per Accertamenti Medico Legali dell'Area Dipendenze Patologiche (AMLDP)

Le Certificazioni Medico Legali che interessano l'Area delle Dipendenze Patologiche vengono erogate da un'apposita articolazione ambulatoriale denominata Ambulatorio per Accertamenti Medico Legali dell'Area Dipendenze Patologiche (AMLDP) ubicato a Parma in via Vasari, 13. L'ambulatorio organizza e gestisce le attività

necessarie al rilascio di certificazioni a valenza medico legale di assenza di tossico/alcol dipendenza,laddove previsto dalla legge. L'attività concerne gli accertamenti sanitari di assenza di tossico/alcol dipendenza in lavoratori addetti a mansioni che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro o particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi, le certificazioni su richiesta della Commissione Medica Locale Patenti dell'AUSL (accertamenti specialistici di II° livello), per il rilascio o rinnovo del porto d'armi o per la presentazione della domanda di adozione internazionale al Tribunale. La UOC inoltre, programma, organizza e gestisce i Corsi Info-Educativi di I° e di II° livello a favore di conducenti sottoposti a provvedimento di sospensione della patente di guida, previsti dalla normativa regionale sulla sicurezza stradale.

Tabella 51 -Attività dell'AMLDP. Anno 2017-2020

Attività	2017	2018	2019	2020
Totale guidatori sottoposti a revisione CML per art 186	445	397	353	100
Totale guidatori sottoposti a revisione CML per art 187	367	212	332	236

Tabagismo: Centro Anti Fumo (CAF)

Nell'Ausl di Parma sono attivi i Centri Antifumo(CAF) di via Pintor presso CdS Molinetto e il CAF di Fidenza ubicato presso i poliambulatori del presidio Ospedaliero di Vaio. I dati dell'utenza che si rivolge ai CAF sono riportati nelle tabelle 45 e 46.

Il numero di pazienti nel 2020 (tabella 52) è di circa la metà rispetto all'anno precedente, passando da 234 a 115 (-51%) e l'utenza si conferma con un'età media più alta rispetto alle altre aree (50 anni) e un rapporto di genere percentuale di genere più equilibrato pari a 1,1 uomini ogni donna (F= 49%).

Tabella 52- Utenti tabagisti: sesso ed età media – Anno 2016-2020

Sesso	2016		2017		2018		2019		2020	
	n	età media	n	età media	n	età media	n	età media	n	età media
F	89	50,7	101	52,8	116	52,7	108	51,4	56	51,8
M	116	50,4	128	52,2	135	53,7	126	50,1	59	50,2
Totale	**205**	**50,5**	**229**	**52,2**	**251**	**53,2**	**234**	**51,0**	**115**	**50,1**

Nella tabella 53 sono riportate alcune caratteristiche degli utenti che hanno intrapreso un programma per la disassuefazione da tabacco tra il 2015 e il 2020 (in totale 932), al fine di provare ad abbozzare un identikit degli utenti dei CAF dell'AUSL di Parma. Dai dati riportati in tabella emerge che, dal 2015 al 2020, le persone che si sono rivolte al CAF, in assenza di precedenti o attuali programmi terapeutici per altre dipendenze, sono prevalentemente di sesso maschile (54%), ma con una distribuzione di genere che rimane abbastanza bilanciata, coniugate (51%) e di cittadinanza italiana (94%). La maggior parte risulta regolarmente occupato (62%) e con un'età di 40 anni o superiore (80%).

Tabella 53 - Nuovi utenti tabagisti 2005-2020

Sesso	**n**	**%**
M	503	54,0
F	429	46,0
Stato civile		
Coniugato	479	51,4
Celibe/nubile	237	25,4
Separato/divorziato	129	13,8
Vedovo	34	3,6
Non rilevato	53	5,7
Cittadinanza		
Italiana	880	94,4
Straniera	52	5,6
Condizione lavorativa	**n**	**%**
Occupato regolarmente	573	61,5
Pensionato	195	20,9
Non occupato regol.	77	8,3
Casalinga	28	3,0
Studente	16	1,7
Non rilevato	43	4,6
Classi d'età		
0-17	4	0,4
18-29	61	6,5
30-39	126	13,5
40-49	227	24,4
50-59	267	28,6
>59	247	26,5

Attività del Comitato Utenti e Famigliari

Nel corso del 2020 gli incontri si sono svolti regolarmente. I principali argomenti trattati sono stati l'aggiornamento delle prospettive e le nuove progettualità delle Associazioni e del DAI-SMDP in merito ai seguenti ambiti:

- presentazione del bilancio preventivo e consuntivo DAI-SMDP
- consultazione sul piano delle azioni aziendale e delle linee progettuali del piano delle attività dipartimentale
- evoluzione ed applicazione del Programma"budget di salute"
- formazione e riflessione sulla figura del "facilitatore sociale" all'interno del progetto regionale volto alla partecipazione degli utenti in collaborazione con Associazioni e Cooperative
- condivisione del programma delle iniziative e degli eventi informativi e formativi promosso dal DAI-SMDP
- consultazione sui documenti regionali relativi ai TSO, all'utilizzo degli psicofarmaci, a Budget di Salute e Residenzialità, alla normativa sulla formazione lavoro, al sostegno dei care giver.
- Aggiornamento e iniziative per Emergenza Pandemia da Covid-19
- Progetti ed Iniziative delle Associazioni
- Aggiornamento Auto Mutuo Aiuto
- Governo Clinico Indagini di Qualità e partecipazione degli utenti e familiari
- Attuazione L.R. 14/2015
- Proposta e Programma annuale 2020-2021
- Rinnovo della Consulta Mandato 2021-2024

Appendice

Abbiamo ritenuto di riportare al termine del report alcuni dati, forniti dal Dipartimento di Sanità Pubblica, su un fenomeno molto rilevante e assai complesso: il suicidio. Esso è correlato con insieme molto ampio di fattori: biologici, psicologici, relazionali, sociali, economici, culturali, religiosi e non si può considerare il mero collegamento con i disturbi mentali. Vengono riportati i dati per rappresentare l'entità del fenomeno, la sua evoluzione nel periodo 2006-2020 e facilitare una riflessione che interroga ciascuno e l'intera comunità. Dopo il picco del 2010-12 seguente alla crisi del 2008, il trend degli ultimi anni pur con un picco nel 2018 è relativamente stabile con uncennodi riduzione. Come si vede il suicidio prevale nei maschi. Rapportato alla popolazione generale, il tasso e' di 7,2 su 100.000 abitanti.

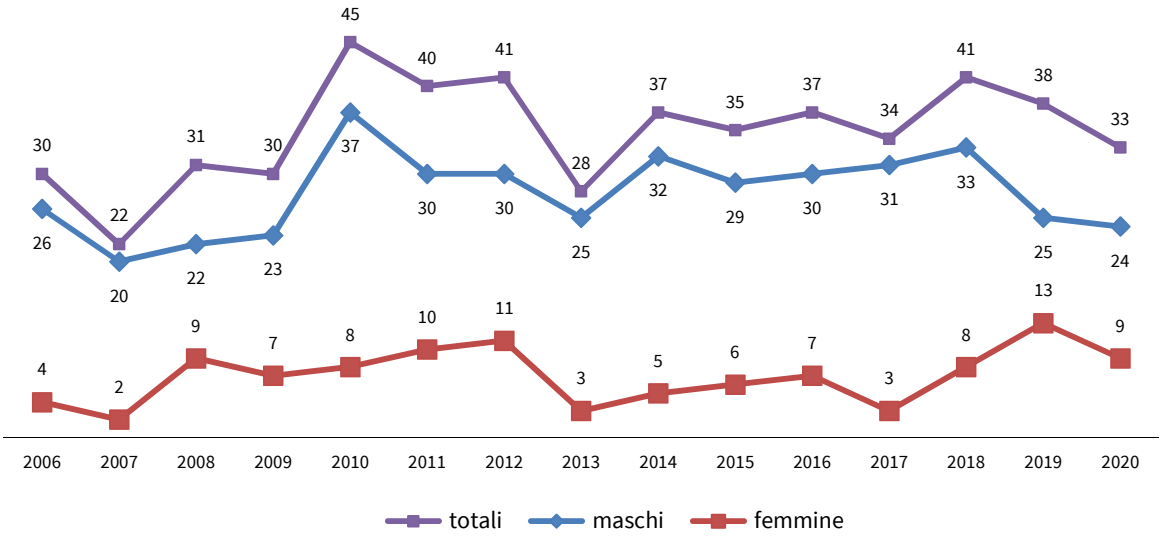


Figura 122 - Suicidi nel territorio della provincia di Parma

Tabella 54 -- Suicidi in provincia di Parma: valori assoluti

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
M	26	20	22	23	37	30	30	25	32	29	30	31	33	25	24
F	4	2	9	7	8	10	11	3	5	6	7	3	8	13	9
Totale	**30**	**22**	**31**	**30**	**45**	**40**	**41**	**28**	**37**	**35**	**37**	**34**	**41**	**38**	**33**

Tabella 55 --Suicidi utenti in cura al DAI SMDP/anno

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Utenti DAI-SMDP	5	3	9	4	4	2	2	5	4	2	4

Note conclusive

Il 2020 è stato caratterizzato dalla pandemia da Covid 19 che ha richiesto una rimodulazione delle attività in tutte le aree del DAI-SMDP che ha sempre garantito l'E-U, gli accessi e la continuità di cura. Il DAI-SMDP ha messo in atto le misure di prevenzione, rimodulato i percorsi territoriale anche mediante la "telepsichiatria" e rivisto la dotazione di posti in SPDC, SPOI, rete residenziale e semiresidenziale (Centro Diurno "diffuso") potenziando le attività domiciliari.

Dal marzo a giugno 2020 la RTI "Presidio Residenziale Psichiatrico (PRP)" è stata dedicato a reparto Covid. Sono state messe in atto anche azioni preventive e di responsabilizzazione dell'utenza mediante uno strumento specifico "Piera (s)". Il DAI-SMDP, per quanto di competenza, ha partecipato alla stesura del Piano Pandemico. Il sistema ha tenuto e alla ripresa di giugno, la lista di attesa dovuta al lockdown, è stata totalmente smaltita entro agosto per la Psichiatria Adulti e a ottobre per NPIA.

La pandemia ha impattato su una situazione che negli ultimi anni ha visto un significativo incremento dell'utenza, in particolare della NPIA (con un aumento dei pazienti in carico di circa il 35% in 4 anni) ed una maggiore complessità psicopatologica e sociale. In questo quadro il DAI-SMDP ha proseguito il lavoro di collaborazione e integrazione interna fra le aree disciplinari.

I dati di attività dei servizi territoriali relativi al secondo semestre 2020 sono in linea o lievemente superiori al corrispondente periodo del 2019, e il trend sta continuando nei primi mesi del 2021.

Alla luce della pandemia il Programma "Leggieri" è stato rivisto valorizzando il servizio di consultazione e consulenza con numeri dedicati ai Medici di Medicina Generale e la presa in cura secondo la Stepped Care, sospendendo invece le attività presso le Case della Salute. Il rapporto con le Cure Primarie è in evoluzione e implica laddove sia possibile un progressivo spostamento di parte delle attività nelle Case della Salute.

Come da programma regionale, a novembre è stata iniziato in forma sperimentale l'utilizzo della Cartella CURE ed è stato attivato l'Ambulatorio infermieristico nei CSM e nelle Residenze. A Parma è stato effettuato un progetto di miglioramento al fine di rivedere il protocollo delle consultazioni- consulenze in Casa Residenza Anziani.

Sul piano gestionale si è registrata una riduzione delle consulenze di PS e nei reparti ed un minore numero dei ricoveri ospedalieri (-26% in SPDC) anche in relazione alla rimodulazione dell'offerta di posti SPDC e SPOI in relazione al covid. Al contempo si rileva un incremento della multiproblematicità dei casi ed una minore tenuta dei contesti familiari e sociali con una degenza media di 15,2 giorni. Anche i ricoveri nell'Ospedalità privata ha visto una riduzione (-6%) per attiene l'OPA Maria Luigia.

Relativamente ai TSO sono invariati rispetto al 2019 il che significa un buona intercettazione delle urgenze. Ai sensi della DGR 1928/2019 sono in revisione i protocolli locali per ASO e TSO.

Le contenzioni in SPDC (14 nel 2017, 5 del 2018, 6 nel 2019, 3 nel 2020) sono rimaste eccezionali e rimane alla portata l'obiettivo di abolirle (ultima il 25 aprile 2020).I reingressi a 8-30 giorni dalla dimissione sono molto bassi pari al 4 su 250.

Prosegue l'applicazione dei PDTA Esordi Psicotici con un incremento 2019-20 da 110 a 129 casi, +17,2%), DCA con incremento complessivo 2019-20 del 47% e nella fascia 12-17 anni da 48 a 87 casi, pari al 81%. E' proseguito il lavoro per la strutturazione dei PDTA relativi all'Autismo e Disturbi del Neurosviluppo con un numero di casi sostanzialmente in linea con il precedente anno. La Tutela minori mostra un incremento che continua anche nel 2021.I percorsi giudiziari sono in linea con l'anno precedente pur di fronte ad un'alta la domanda. E' stato elaborato il PDTA Multicomplessità.

Su indicazione regionale a maggio 2020 è stato attivato il Tavolo Residenze e Budget di Salute con tutti i gestori. Acquisendo le innovazioni, è stato rinnovato l'accordo Quadro per le attività sociosanitarie del 2015 mentre la Co-progettazione per la Fattoria di Vigheffio è stata prorogata al 30 settembre 2021. E' in atto la revisione dei Servizi per il Distretto di Fidenza e da luglio 2020 d'intesa con il Distretto di Fidenza, il DAI-SMDP è referente per la Struttura "Il Ponte".

Per il Budget di salute sono in atto sia un programma regionale di cui il DAI-SMDP è capofila e sia uno nazionale coordinato dall'Istituto Superiore di Sanità nel quale il DAI-SMDP è partner insieme alla Regione Emilia Romagna.

Il Dipartimento ha proseguito l'attività di coordinamento del tavolo regionale dedicato all'implementazione della metodologia di intervento Budget di Salute ed ha avviato il Progetto"SOGGETTO, PERSONA, CITTADINO: PROMUOVERE IL BENESSERE E L'INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE CON DISTURBI MENTALI ATTRAVERSO il Budget di Salute", finanziato dal il Ministero della Salute e promosso dal Servizio Assistenza Territoriale – Area Salute Mentale e Dipendenze Patologiche della Regione. E' stato inoltre realizzato il focus group dedicato al percorso UVM nel Budget di Salute, già inserito nei Piani di Zona del Distretto di Parma. Per i percorsi giudiziari il DAI-SMDP è riferimento regionale e nazionale (Agenas).

Essendo stata posticipata l'apertura della REMS di Reggio Emilia, prevista a novembre 2019, sono proseguite le attività della REMS temporanea di Casale di Mezzani. A giugno 2020 l'attivazione dei primi 50 dei 200 nuovi posti negli Istituti di Pena di Parma ha comportato una rivalutazione della dotazione della UO Salute mentale dipendenze negli II.PP. A novembre 2019 è iniziata la collocazione a Vaio del PRP mentre è stato rinviato il trasferimento del CSM e SerD.

La RTI-Minori di San Polo di Torrile con riferimento AVEN, seppure con un ridotto numero di posti (6 invece di 8 per assicurare il distanziamento) ha continuato le attività ed è stata completato l'ampliamento.

Nella Casa della Salute per il Bambino e l'Adolescente di Parma sono in atto i programmi di prevenzione, educazione e sostegno dei genitori, coinvolgimento delle associazioni e della comunità. Persiste il problema della lista di attesa per gli accessi tramite CUP. Nel 2020 specie nel secondo semestre aumenti di richieste anche in E-U per disturbi comportamentali, autolesioni e TS, DCA, Eventi sfavorevoli dell'Infanzia.

A fine 2019 sono stati stipulati/rinnovati gli accordi distrettuali per la tutela minori e l'applicazione della DGR n. 1102/2014. Il relativo cruscotto ha assicurato il monitoraggio determinato un miglioramento della qualità e dell'appropriatezza con diversificazione dei percorsi anche per fare fronte ad una domanda crescente passata da una media di 23-25 minori del 2015 ad una media di circa 60 casi del 2020.

Si è data attuazione alle DGR 212/2016 e 640/2019 sui Disturbi dello Spettro Autistico per assicurare la diagnosi e l'intervento precoce (fascia 0-6 anni). Va rilevato un significativo aumento dell'incidenza (le diagnosi sono passate da 15-20/ anno di inizio 2010 a 70 nel 2020). Vi è una sempre maggiore rilevanza dei problemi posti da adolescenti e giovani adulti affetti da Disturbi dello Spettro Autistico e Neurosviluppo per i quali si stanno predisponendo risposte specifiche.

Per le Dipendenze Patologiche continua la collaborazione con gli Enti Accreditati e prosegue il PDTA per il Gioco d'Azzardo Patologico. E' in corso di realizzazione il PDTA per i disturbi alcool correlati. Sono state attivate le procedure per l'acquisizione di nuove tecnologie come la Stimolazione Magnetica Transcranica. Sono stati rinforzati i programmi di prevenzione, innovazione e ricerca.

Qualità-accreditamento e governo clinico sono stati rimodulati e sono stati sviluppati i PDTA innovativi come quello della "Multicomplessità", attenzione alla medicina di genere. Sono state effettuate indagini di Qualità percepita e attivati Audit su "Abitare in sicurezza" e "Prevenzione del soffocamento".

Costante attenzione è stata data alla partecipazione, al clima interno e alla motivazione del personale anche tramite la formazione a cui va aggiunto sempre il lavoro sulla aspettative dell'utenza e dei contesti nonché lo stigma e l'abbandono delle diversità (comunicazione, revisione del sito). Con la componente universitaria l'attività didattica e di ricerca è proseguita con un numero di pubblicazione (media 80 anno) e continuano i programmi e gruppi di ricerca del Centro Studi.

Nell'ambito delle attività per la valorizzazione professionale è continuata l'attività del coordinamento delle Assistenti sociali.

L' utilizzo degli psicofarmaci è monitorato anche attraverso audit specifici (regionali e locali) per migliorare appropriatezza e sicurezza anche tramite l'Ambulatorio infermieristico che realizza attività di promozione della salute, di corretti stili di vita e di prevenzione della sindrome metabolica. Si è registrato un incremento del 14,3% soprattutto per il maggiore utilizzo dei farmaci antipsicotici depot in relazione alle restrizioni poste dalla pandemia ma soprattutto per un cambiamento degli orientamenti tecnico scientifici. D'intesa con il Dipartimento del Farmaco verranno realizzati focus e incontri di formazione.

Nel corso del 2020 il DAISMDP ha perseguito azioni di consolidamento di un'organizzazione che pur tenendo conto delle specificità delle aree disciplinari è orientata a superare la frammentazione degli interventi per offrire percorsi di cura realmente integrati ed unitari, favorendo altresì il protagonismo degli utenti.In questo spirito sono state ulteriormente diffuse all'interno dei servizi le esperienze di auto-mutuo-aiuto e sono state svolte azioni di sensibilizzazione e formazione sul tema degli "esperti per esperienza".

La Casa della Salute per il Bambino e l'Adolescente, inaugurata nel corso del 2018 e in piena attività nel 2019, è stata oggetto di un'indagine di qualità percepita realizzata in collaborazione di "utenti esperti" ed associazioni di utenti/familiari, che ha rilevato un elevato indice di soddisfazione.

L'attività di monitoraggio e verifica garantita dalle funzioni di "cruscotto dipartimentale" ha consentito una migliore percezione dei bisogni dell'utenza e la conseguente riprogrammazione dei servizi.

In applicazione delle raccomandazioni regionali in tema di percorsi di cura per adolescenti e giovani adulti si sono realizzate in ogni distretto le equipe Equipe Funzionali per Percorsi di Cura a favore di Adolescenti e giovani adulti.

Il dipartimento ha garantito la piena attuazione della normativa regionale L.14/2015, in merito ai percorsi inerenti la formazione lavoro rivolta agli utenti dei servizi, anche in collaborazione con le agenzie esterne a livello distrettuale.

In tema di governo clinico e gestione del rischio è proseguito l'attività di costante monitoraggio e ottimizzazione dell'appropriatezza nei percorsi di cura e riduzione del rischio. Nell'ambito delle attività di promozione della salute, è stata effettuata la Rassegna sulla Salute Mentale. In conclusione, alla luce dei dati esposti il presente report vuole facilitare la partecipazione auspicando un miglioramento delle conoscenze e il superamento delle stigma ed essere spunto per ulteriori riflessioni che potranno essere inviate al DAI-SMDP.

La presente relazione e' stata redatta da

Leonardo Tadonio e Barbara Cantarelli
(Osservatorio sulle Dipendenze)
e
Stefano Giovanelli
(Ufficio Sistema Informativo DAISM DP)